MINISTERIO DE SALUD

No. 361-2026/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 08 de ABRIL del 2026

VISTO, el Expediente N° DGIESP-DSARE20240000093, que contiene la Nota Informativa N° D001106-2024-DGIESP-MINSA que adjunta la Nota Informativa N° D000170-2024-DGIESP-DSARE-MINSA y el Informe N° D000003-2024-DGIESP-DSARE-SRS-MINSA, la Nota Informativa N° D000671-2025-DGIESP-MINSA que anexa la Nota Informativa N° D000118-2025-DGIESP-DSARE-MINSA y el Informe N° D000003-2025-DGIESP-DSARE-SRS-MINSA, el Memorándum N° D005466-2025-DGIESP-MINSA que adjunta la Nota Informativa N° D000540-2025-DGIESP-DSARE-MINSA y el Informe N° D000020-2025-DGIESP-SARE-SRS-MINSA, y la Nota Informativa N° D000166-2026-DGIESP-MINSA, que adjunta la Nota Informativa N° D000030-2026-DGIESP-DSARE-MINSA, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el Informe N° D000307-2026-OGAJ-MINSA, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, los artículos 5 y 6 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que toda persona tiene derecho a ser debida y oportunamente informada por la autoridad de salud sobre medidas y prácticas de salud reproductiva, entre otras; así como tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir, con carácter previo a su prescripción o aplicación, información adecuada sobre los métodos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede ocasionar;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala como ámbito de competencia del Ministerio de Salud, la salud de las personas; y, el artículo 4 dispone que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la citada Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establecen como funciones rectoras del

Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, entre otros;

Que, el artículo 1 de la Ley N° 32535, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, establece que esta Ley tiene por objeto establecer el marco normativo e institucional para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, proscribiendo toda forma de discriminación basada en el sexo y promoviendo la igualdad en los ámbitos político, laboral, económico, social, cultural y en cualquier otra esfera, de conformidad con la Constitución Política del Perú;

Que, así mismo, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley N° 32535, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, contempla que el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una herramienta que busca equilibrar las relaciones entre ambos, sobre la base del derecho a la igualdad, la dignidad, el libre desarrollo, el bienestar y la autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de la vida pública y privada y promueve la plena igualdad de oportunidades, reconociendo las particularidades que los distinguen y complementan;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas en Salud Pública en materia de salud sexual y reproductiva, entre otras;

Que mediante Resolución Ministerial N° 290-2006/MINSA se aprueba el "Manual de Orientación/Consejería en Salud Sexual y Reproductiva";

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha propuesto la actualización del precitado Manual, al estar en un contexto de mayores demandas de atención y consejería para el abordaje de la salud sexual y reproductiva;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Dirección General de Operaciones en Salud, de la Dirección General de Personal de la Salud, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaría General, del Despacho Viceministerial de Salud Pública, y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Manual de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

MINISTERIO DE SALUD

No. 361-2026/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 08 de ABRIL del 2026

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 290-2006/MINSA, que aprueba el "Manual de Orientación/Consejería en Salud Sexual y Reproductiva".

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO
Ministro de Salud

MINISTERIO DE SALUD · REPUBLICA DEL PERU · MINISTRO

MINISTERIO DE SALUD · Viceministerio de Salud Pública · H. RERAZ

MINISTERIO DE SALUD · Dirección General de Personal de la Salud · C. ESPINOZA B.

MINISTERIO DE · C. VILA

MINISTERIO DE SALUD · O.G. ASESORÍA JURÍDICA · J.F. OCHOA

MINISTERIO DE SALUD · DIRECCIÓN GENERAL · B. OSTOS

MINISTERIO DE SALUD · L. LORO

MINISTERIO DE SALUD · Secretaría General · J. NIÑO

DOCUMENTO TÉCNICO: MANUAL DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 3
II. FINALIDAD 3
III. OBJETIVOS 3
3.1. OBJETIVO GENERAL 3
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 4
V. BASE LEGAL 4
VI. CONTENIDO 5
6.1. DEFINICIONES OPERATIVAS 5
6.2. PRINCIPIOS QUE SE PRACTICAN EN LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 7
6.3. ENFOQUES DE LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 7
6.3.1. ENFOQUE DE DERECHOS 7
6.3.2. ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD 8
6.3.3. ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD 8
6.3.4. ENFOQUE DE INTEGRALIDAD 8
6.3.5. ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL EN SALUD 8
6.4. POBLACIÓN OBJETIVO PARA LA CONSEJERÍA 9
6.5. RECURSOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 9
6.5.1. PERSONAL QUE BRINDA LA CONSEJERÍA 9
6.5.2. AMBIENTE FÍSICO 9
6.5.3. MATERIAL DE APOYO PARA LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 10
6.6. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - MODELO DE LOS 5 PASOS 10
6.7. CONSEJERÍA EN TEMAS ESPECÍFICOS 13
6.7.1. CONSEJERÍA EN SEXUALIDAD 13
6.7.2. CONSEJERÍA PRECONCEPCIONAL 14
6.7.3. CONSEJERÍA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 15
6.7.4. CONSEJERÍA EN ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA 19
6.7.5. CONSEJERÍA DURANTE EL EMBARAZO Y EN EL POST PARTO 20
6.7.6. CONSEJERÍA EN ATENCIÓN DEL PARTO CON PERTINENCIA CULTURAL 22
6.7.7. CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA 23
6.7.8. CONSEJERÍA EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA POR INDICACIÓN TERAPÉUTICA DEL EMBARAZO MENOR DE 22 SEMANAS CON CONSENTIMIENTO INFORMADO 24
6.7.9. CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR 25
6.7.10. CONSEJERÍA PARA MUJERES EN LA ETAPA DEL CLIMATERIO 28

6.7.11. CONSEJERÍA EN PROBLEMAS DE FERTILIDAD....29
6.7.12. CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER....30
6.7.13. CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIH Y HEPATITIS B....31
6.7.14. CONSEJERÍA EN LA TRANSMISIÓN SEXUAL DEL VIRUS ZIKA....33
6.8. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A GRUPOS ESPECÍFICOS....35
6.8.1. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES....35
6.8.2. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA VARONES....37
6.8.3. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD....37
6.8.4. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD....38
6.9. REGISTRO E INFORMACIÓN....39
VII. RESPONSABILIDADES....39
VIII. ANEXOS....40
IX. BIBLIOGRAFÍA....45

I. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud, en cumplimiento de su función rectora establece políticas en materia de salud a nivel nacional, pone a disposición del personal de la salud el presente Documento Técnico: Manual de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, como una herramienta de ayuda para promover y generar cambios positivos en las personas, especialmente relacionados con estilos de vida y cuidado de su salud sexual y reproductiva, así como la toma de decisiones responsables basadas en el conocimiento y la información oportuna.

Las sociedades que aspiran al desarrollo humano deben velar por la salud y el bienestar de las personas, entre ellos la salud sexual y reproductiva, considerándose este como un derecho y una condición esencial para que los hombres y mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo, su salud, su vida sexual sin discriminación, coacción ni violencia; para ello, la persona usuaria requiere de información oportuna, completa y confiable, así como de servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.

En consecuencia, con el presente documento normativo se pretende establecer medidas que aseguren a las personas el ejercicio de sus derechos, mediante la consejería en salud sexual y reproductiva, que se convierte en un procedimiento clave que no sólo proporciona información a las personas, sino que ayuda a entender los factores determinantes de una situación de salud, apoya el análisis de sus circunstancias individuales o de pareja, para que tomen decisiones responsables, fomentando actitudes de confianza que posibilite a decidir y actuar con autonomía.

La consejería en salud sexual y reproductiva desarrolla una metodología específica de la comunicación interpersonal, cuyo fin es motivar la reflexión y toma de decisiones libres e informadas, constituye una actividad de primer orden en la atención de salud y en la calidad de los servicios, por lo que, amparados en los compromisos nacionales e internacionales de protección del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se ha elaborado el Documento Técnico: Manual de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva.

El presente Documento Técnico aborda los aspectos más relevantes de salud sexual y reproductiva; y, considera los principios y enfoques de la consejería, el procedimiento general para la consejería con el modelo de los 5 pasos, define las responsabilidades y características del consejero, así como los recursos necesarios para su atención. Entre los contenidos temáticos tenemos: Consejería en sexualidad, consejería preconcepcional, planificación familiar, prevención y atención de violencia, climaterio, consejería para la atención intercultural del parto, prevención de factores de riesgo para el cáncer, infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y hepatitis B (HB), entre otros.

Asimismo, este Documento Técnico contribuye al empoderamiento de las mujeres en el conocimiento, autocuidado y actitudes positivas sobre su salud sexual y reproductiva, favorece su autonomía para la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones, libres de violencia y discriminación.

II. FINALIDAD

Contribuir al cuidado y ejercicio consciente de los derechos de salud sexual y reproductiva de las personas.

III. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos básicos y metodológicos para la consejería en salud sexual y reproductiva que se brinda en los establecimientos de salud, que permita a la persona usuaria el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Establecer contenidos básicos de la salud sexual y reproductiva para asegurar la información con calidad y oportunidad en la consejería, según necesidades y características de la persona usuaria.

3.2.2 Brindar herramientas conceptuales y metodológicas a los profesionales de la salud para proveer consejería en salud sexual y reproductiva sobre los cuidados y riesgos asociados a la conducta sexual.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Documento Técnico es de aplicación en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, a cargo de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS); y, de los Gobiernos Regionales, a cargo de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA) o las que hagan sus veces a nivel regional. Es referencial para el Seguro Social de Salud (EsSALUD), Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los Gobiernos Locales y los privados que desarrollen actividades de consejería en salud sexual y reproductiva.

V. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.
- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 008-2019-SA, que aprueba el "Protocolo de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer – CEM y los Establecimientos de Salud – EE.SS. para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364, y personas afectadas por violencia sexual".
- Resolución Ministerial N° 278-2008/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Adecuación Cultural de la Orientación / Consejería en Salud Sexual y Reproductiva".
- Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, que aprueba la NTS N°124-2016/MINSA-V.01: Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 227-2019/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 083-MINSA/2019/DGIESP: "Directiva Sanitaria para el Uso del Kit para la Atención de Casos de Violencia Sexual".
- Resolución Ministerial N° 1138-2019/MINSA, que aprueba la NTS N° 159-MINSA/2019/DGIESP: Norma Técnica de Salud para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH, Sífilis y Hepatitis B.
- Resolución Ministerial N° 649-2020/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N°164-MINSA/2020/DGIESP: Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral a Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Afectados por Violencia Sexual.
- Resolución Ministerial N° 299-2024/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Definiciones Operacionales y Criterios de Programación del Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal.
- Resolución Ministerial N° 480-2025/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 165-MINSA/DGIESP-2025, Directiva Sanitaria para la prevención del cáncer de cuello uterino.

VI. CONTENIDO

6.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- **Atención de salud**
  Se denomina así a cada uno de los servicios que recibe o solicita una persona usuaria de los servicios de salud. Pueden ser de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, según corresponda; y, pueden brindarse dentro del establecimiento de salud (atenciones intramurales) o en la comunidad (atenciones extramurales).

- **Atención integral de salud**
  Es el conjunto de intervenciones sanitarias en los ámbitos personal, familiar y comunitario, enfocadas en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, teniendo en cuenta los aspectos físico, mental y social, provistas de manera conjunta y continua por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en términos de calidad, equidad y oportunidad; de acuerdo con su nivel resolutivo y la capacidad de oferta de los servicios de salud que brindan.

- **Atención integral de salud sexual y reproductiva**
  La salud sexual y reproductiva tiene un enfoque integral, que abarca todo el ciclo de vida de las personas (niño, adolescente, adulto y adulto mayor). Para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación específicas y diferenciadas durante cada una de las etapas del ciclo de vida de las personas, debido a que las necesidades en el área sexual y reproductiva son cambiantes durante todo el ciclo de vida. El concepto lleva implícito el derecho que tienen todas las personas de adoptar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva y a que sus decisiones sean respetadas sin discriminación alguna

- **Consejería**
  Es el proceso de comunicación interpersonal en el que se brinda la información necesaria para que las personas individuales o parejas tomen decisiones voluntarias, informadas y satisfactorias, además de brindar apoyo para el análisis y búsqueda de solución a sus problemas de salud.

- **Consentimiento informado en materia de planificación familiar**
  Es el acto en el que la persona expresa voluntariamente su aceptación para que se le realice un procedimiento anticonceptivo, como resultado de un proceso de información detallada sobre todos los aspectos del uso de la anticoncepción que permitan la toma de decisión, el cual puede suspenderse en cualquier momento a solicitud de la propia persona. El consentimiento informado puede ser revocado y es expresado en la misma forma en que fue otorgado. El consentimiento escrito debe ejecutarse de forma obligatoria cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona.

- **Derechos sexuales**
  Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, lo cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la sexualidad y a la salud sexual. Protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual, con el debido respeto por los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a la discriminación.

- **Derechos reproductivos**
  Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

- **Equidad en salud**
  Implica la disminución de las diferencias evitables e injustas en salud que responden a desigualdades sociales y económicas a fin de generar las condiciones que permitan que toda persona, y, en especial, los grupos que viven en pobreza o vulnerabilidad tengan las mismas oportunidades para vivir con salud.

- **Interculturalidad en salud**
  Los servicios de salud se realizan bajo el enfoque de interculturalidad, el cual implica la adaptación de los procesos que sean necesarios, en función a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de quienes acceden y forman parte del servicio. Estos servicios deben ser brindados sin ningún tipo de discriminación debido a la raza, edad, sexo, religión, idioma, condición social o cualquier otra situación.

- **Material de apoyo para la consejería**
  Es aquel medio informativo que el consejero utiliza para el desarrollo del proceso de la consejería con la finalidad de facilitar el entendimiento de la persona usuaria respecto a sus necesidades de salud motivo de consulta.

- **Riesgo reproductivo**
  Probabilidad que tiene tanto la mujer en edad fértil como su producto de experimentar enfermedad, lesión o muerte en caso de presentarse un embarazo.

- **Salud sexual**
  Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no es simplemente la ausencia de enfermedades, disfunciones o dolencias. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coerción, discriminación y violencia. Para alcanzar y mantener la salud sexual, es necesario respetar, proteger y ejercer los derechos sexuales de todas las personas.

- **Salud reproductiva**
  Es un estado de bienestar físico, mental y social que no consiste solamente en la ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos referentes al sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Por consiguiente, la salud reproductiva implica que la gente pueda llevar una vida sexual segura y satisfactoria, teniendo la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir cuándo y cuán a menudo hacerlo. En esta última condición está implícito el derecho de los varones y mujeres a mantenerse informados con respecto a los métodos anticonceptivos seguros, aceptables y al alcance de sus posibilidades, a elección suya, y a tener acceso a los mismos, así como a otros métodos de planificación familiar para regular la fertilidad, que no sean contrarios a la ley, además del derecho de acceder a servicios apropiados de salud que permitan que las mujeres tengan un embarazo y un parto seguros, proporcionando a las parejas las mejores oportunidades de tener un bebé sano.



- **Sexualidad**
  Es una dimensión del desarrollo humano presente a lo largo del ciclo de vida, relacionada con las características biológicas del sexo, la identidad personal, los vínculos afectivos, la reproducción y las conductas asociadas, y que se expresa en la manera en que las personas se relacionan consigo mismas y con los demás. Su vivencia está influida por factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, y debe desarrollarse en el marco del respeto, la responsabilidad y la salud integral.

- **Violencia**
  Es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra una persona, grupo o comunidad, inclusive contra uno mismo, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.

- **Violencia sexual**
  Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.

6.2. PRINCIPIOS QUE SE PRACTICAN EN LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- **Confidencialidad**
  El consejero mantiene en reserva la información que la persona usuaria le confía durante la consejería y no la revela a terceras personas ajenas a la atención.

- **Privacidad**
  El consejero garantiza la privacidad de la persona para que no sea observada por otro u otros individuos.

- **Respeto a la dignidad humana**
  El consejero establece una relación cordial de respeto y horizontalidad con la persona usuaria, lo cual le genera confianza para compartir sus sentimientos, dudas y temores. Se respeta su dignidad humana, evitando cualquier elemento que signifique discriminación, sea étnica, cultural, generacional, sexual, entre otros, lo que genera confianza para compartir sus sentimientos, dudas y temores.

- **Orientar y no direccionar**
  El consejero brinda información clara, completa y comprensible, lo cual permite a la persona usuaria mejorar sus conocimientos y capacidades para que tome sus propias decisiones con libertad y acorde con sus convicciones.

- **Imparcialidad y no discriminación**
  El consejero es respetuoso y se abstiene de dar su opinión sobre cualquier asunto que la persona usuaria lleve a la consulta; es imparcial, no juzga la conducta, aún cuando no esté de acuerdo con lo que dice o hace.

6.3. ENFOQUES DE LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

6.3.1. ENFOQUE DE DERECHOS

Entre los derechos sexuales y reproductivos tenemos:

- Decidir libre y responsablemente sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo.
- A recibir información sobre salud sexual y reproductiva de manera individual o en pareja.

- Tener acceso, en condiciones de igualdad, sin discriminación por edad, sexo, estado civil, religión, creencias, entre otros a los servicios de atención que incluyan la salud sexual y reproductiva.
- A la libre elección y acceso informado al método anticonceptivo que elija.
- A ser atendidos en salud reproductiva sin ningún tipo de coacción.
- A que las instituciones de salud velen porque se cumplan estos derechos en todas las fases de atención.

A través de la consejería se busca promover la igualdad en el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres, lograr que los hombres en su calidad de compañeros sexuales y de parejas, participen e intervengan por igual en la vida reproductiva, se responsabilicen de su comportamiento sexual y reproductivo, y asuman un rol más participativo dentro de las familias y comunidad, por lo que:

- El consejero aborda con la persona usuaria diversos mecanismos de información sobre sus derechos sexuales y reproductivos que le permita afrontar sus dudas y temores y fortalecer su autoestima y cuidados.
- Promueve la participación y responsabilidad de los varones en la salud sexual y reproductiva.
- Brinda información y facilita el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las personas usuarias (hombres y mujeres), considerándolos como sujetos de derechos sexuales y reproductivos.

6.3.2. ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD

La atención en los servicios de salud sexual y reproductiva considera y promueve el reconocimiento y respeto de la existencia de diversidades socio culturales, lo que implica el conocimiento, comprensión, interés y acción del personal de la salud para conciliar sus conocimientos, actitudes y competencias con las características culturales, étnicas, lingüísticas, edad, nivel educativo, religiosas y socioeconómicas de la población a la que atiende, introduciendo adaptaciones en la atención.

El consejero tiene habilidades para interactuar y responder a las diversas necesidades relacionadas a la salud sexual y reproductiva de las personas:

- Es respetuoso de las expresiones culturales.
- Promueve la adecuación cultural de los servicios que beneficien a la persona usuaria.
- En lo posible, trata de comunicarse en el idioma de la persona usuaria.
- Si es necesario, recurre a los agentes comunitarios de salud para conocer mejor las condiciones y necesidades de salud de la persona usuaria.
- Utiliza materiales informativos adecuados culturalmente.

6.3.3. ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD

En los servicios de salud sexual y reproductiva se promueve el principio de igualdad y no discriminación, buscando en la persona usuaria generar su autocuidado y empoderamiento para desarrollar capacidades personales, sociales y económicas que permitan minimizar su vulnerabilidad por la interacción de subordinación creada por su origen étnico, religión, estrato social, discapacidad, nacionalidad, lengua materna o cualquier circunstancia que pueda afectar su vida.

6.3.4. ENFOQUE DE INTEGRALIDAD

Los servicios de salud sexual y reproductiva tienen una mirada integral, reconocen las necesidades de salud de las personas y la necesidad que las acciones de salud se amplíen hacia su entorno (familia y comunidad), según curso de vida y priorización de problemas específicos de salud.

6.3.5. ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL EN SALUD

Los servicios de salud sexual y reproductiva promueven atención con calidad y oportunidad para todos, eliminando barreras de acceso a la atención y a mejores

condiciones de salud, sin discriminación por razones de etnia, sexo, estrato social, discapacidad, religión y cultura, priorizando a las personas en situación de marginación, vulnerabilidad y riesgo.

6.4. POBLACIÓN OBJETIVO PARA LA CONSEJERÍA

Son todas las personas con necesidades de atención de su salud sexual y reproductiva.

6.5. RECURSOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

6.5.1. PERSONAL QUE BRINDA LA CONSEJERÍA

La consejería en salud sexual y reproductiva es realizada por el profesional en obstetricia, médico especialista en ginecología y obstetricia, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, o médico cirujano capacitado en consejería en salud sexual y reproductiva, habilidades blandas e interculturalidad.

De no contar con los profesionales señalados, la consejería en salud sexual y reproductiva puede ser realizada por otros profesionales de la salud que, por sus características de formación profesional, puedan desarrollar la actividad previa capacitación en consejería en salud sexual y reproductiva, habilidades blandas e interculturalidad.

El consejero cuenta con las siguientes habilidades:

- Hablar con la verdad. Brindar información completa para asegurar decisiones libres y voluntarias procurando que la comunicación sea accesible e inclusiva para personas con discapacidad sobre cuidados, atenciones y necesidades de salud sexual y reproductiva.
- Mantener una comunicación horizontal con la persona usuaria, permitiéndole expresarse con libertad y confianza, respetando las diferencias socioculturales, manteniendo siempre la confidencialidad y privacidad en todo el proceso de la consejería.
- Es respetuoso de los derechos en salud y las diferencias socioculturales, como la edad, sexo, etnia, religión, educación, entre otras, de la persona usuaria.
- Mantener la "*escucha activa*", es decir, observar atentamente la conducta verbal y no verbal de la persona usuaria, "*escuchar no sólo lo que dice, sino cómo lo dice*", explorar hechos y sentimientos.
- Estar motivado durante la consejería, asumiendo un rol activo para identificar las necesidades, dificultades, expectativas y sentimientos de los usuarios.
- Promover la participación de la persona usuaria para que, en base a la información obtenida de sus antecedentes, se elabore un plan de apoyo que resuelva sus necesidades de salud sexual y reproductiva.
- Ser responsable, comprometerse con las personas, las tareas y con los pasos a seguir para alcanzar los objetivos acordados en la consejería.
- Mantener discreción, reserva y confidencialidad de la información recibida.

Adicionalmente, el consejero cumple con las siguientes responsabilidades:

- Organiza el ambiente físico donde se brinda la consejería en salud sexual y reproductiva, procurando un ambiente que ofrezca confort en el servicio.
- Mantiene actualizados los registros de las personas usuarias del servicio de consejería en salud sexual y reproductiva, en la historia clínica y en el sistema de registro diario de atenciones.

6.5.2. AMBIENTE FÍSICO

La consejería en salud sexual y reproductiva en el establecimiento de salud se realiza en ambientes accesibles, cómodos y aceptados culturalmente por las personas usuarias, que aseguren la privacidad visual y auditiva durante la atención.

Para la consejería extramural y en el hogar durante la visita domiciliaria, se adecuan ambientes procurando que se cumpla con la privacidad y comodidad.

6.5.3. MATERIAL DE APOYO PARA LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Los materiales de comunicación o de apoyo constituyen una herramienta importante en la interacción entre la persona usuaria y el proveedor de salud en el proceso de la consejería.

Los materiales utilizados deben ser apropiados a las características culturales, inclusivos y accesibles, así como adecuados a las necesidades de comunicación de las personas usuarias, con información escrita o visual completa, con lenguaje comprensible, tanto en la redacción como en la representación gráfica, con ilustraciones simples y apropiadas para la persona usuaria. El material es utilizado durante la consejería y algunos son entregados al final de la sesión para reforzar la información.

Entre los materiales de apoyo, tenemos:

- Rotafolio de diversos temas en salud sexual y reproductiva.
- Trípticos, dípticos.
- Muestrario de métodos anticonceptivos.
- Modelos anatómicos.
- Videos.
- Registros, formatos.
- Directorios telefónicos de principales instituciones que brindan apoyo, soporte social y acceso a la justicia entre otros.

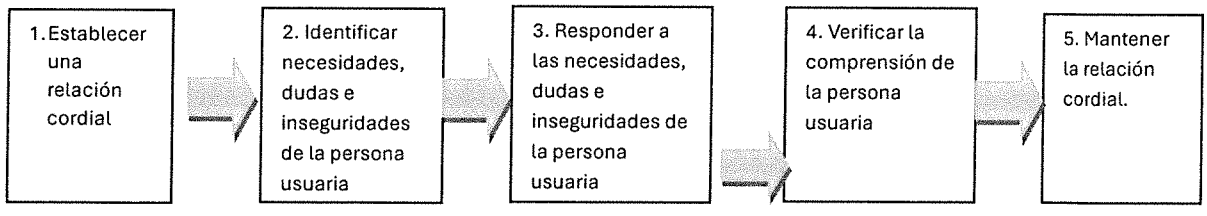
6.6. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - MODELO DE LOS 5 PASOS

La consejería en salud sexual y reproductiva utiliza una metodología y tiene una secuencia que va desde la apertura hasta el cierre de la sesión, y cada paso cumple un objetivo específico; la interacción inicial es fundamental para asegurar el intercambio de información que sea satisfactorio para los participantes o actores de la sesión.

El modelo de los 5 pasos configura una estructura de la consejería y permite una articulación secuencial de la temática y favorece la comprensión y toma de decisiones. Sin embargo, el proveedor puede estar frente a situaciones que van a posibilitar abreviar algunos pasos y profundizar otros, lo cual depende de las necesidades de la persona usuaria, así como de la complejidad del tema de salud a abordar, donde es posible un mayor número de sesiones de consejería.

La consejería es un proceso que tiene una duración aproximada de 30 minutos y se puede organizar en 5 pasos o momentos:

- **Primer Paso:** Establecer una relación cordial.
- **Segundo Paso:** Identificar necesidades, dudas e inseguridades de la persona usuaria.
- **Tercer Paso:** Responder a las necesidades, dudas e inseguridades de la persona usuaria.
- **Cuarto Paso:** Verificar la comprensión de la persona usuaria.
- **Quinto Paso:** Mantener la relación cordial.





PRIMER PASO: ESTABLECER UNA RELACIÓN CORDIAL

El objetivo de este paso es crear un clima de confianza que facilite a la persona usuaria la expresión abierta de sus sentimientos, preocupaciones, intereses y/o problemas, saber con claridad quién lo está atendiendo y qué es lo que le puede brindar el proceso de consejería. Es muy importante el trato cálido y amable reforzado por el interés en aquello que viene a consultar.

Acciones claves:

- Recibir amablemente a la persona usuaria, en un ambiente confortable y adecuado culturalmente, sumado al enfoque inclusivo, por condición de discapacidad; saludar, adoptando una actitud amable, respetuosa, procurando crear un clima de confianza.
- Identificarse claramente diciendo su nombre y cargo (ocupación); tener presente el estado emocional en el que se encuentra la persona usuaria para dialogar con tranquilidad los temas sobre su sexualidad y anticoncepción.
- Recuerde que la voz y el tono refleja en gran medida el estado de ánimo, así puede denotar preocupación, cansancio, desinterés, entre otros.
- Establecer un ambiente de confianza, brinde muestras de privacidad y confidencialidad, acordando con la persona usuaria algunas acciones, como cerrar la puerta del consultorio (protección con biombos, cortinas, entre otros), así como en el domicilio a comodidad de la persona usuaria. La mayoría de las personas usuarias habla más libremente si tiene la impresión de que la conversación no es escuchada por otras personas. Es preferible evitar equipos, aparatos o distractores.
- Evitar gestos, actitudes de desaprobación o de risa con alguna de las preguntas, creencias o situaciones que esté refiriendo la persona usuaria, ya que esto bloquea la comunicación.
- Prestar toda su atención, utilizar la escucha activa que motive a continuar con el diálogo; asegurarse si la persona usuaria prefiere que el consejero sea de su mismo sexo o no.
- Mostrar respeto por las creencias culturales y religiosas, valores personales, las condiciones de vida y los derechos en salud sexual y reproductiva.
- Identificar claramente el motivo de la consulta y/o entrevista durante la visita domiciliaria.

SEGUNDO PASO: IDENTIFICAR LAS NECESIDADES, DUDAS E INSEGURIDADES DE LA PERSONA USUARIA

El objetivo de este paso es determinar las características y necesidades de atención de salud de la persona usuaria que acude al servicio, de la misma forma en caso que la atención se desarrolle en el domicilio. Este momento es decisivo en la consejería, pues aquí la persona usuaria puede expresar sus preocupaciones, necesidades y dudas, y el consejero hace un reconocimiento sobre las características de la persona usuaria.

Acciones claves:

- Practicar la empatía para tratar de comprender cómo se siente y ayudar a la persona usuaria a comunicar alguna situación que le puede ocasionar vergüenza o que no quiere expresar, pues, por lo general, piensa que no se le va a entender.
- En todo momento se debe escuchar a la persona usuaria con atención, con un gesto agradable y mirando a sus ojos.
- Las preguntas que se realicen deben permitir, además de entender el motivo de consulta y cómo se está sintiendo, comprender el contexto personal, familiar y social en que vive la persona usuaria.
- Es necesario tener paciencia; a veces la persona usuaria da rodeos, quiere estar segura de que se va a comprender antes de decir lo que realmente les preocupa.
- También es importante estar atentos a los mensajes no verbales de la persona usuaria: Su postura, el movimiento de sus manos, los silencios entre sus palabras, entre otros.
- Si muestra tensión, miedo o se pone a la defensiva, mantener una escucha activa sin interrumpir, demostrando interés con un silencio comprometido.
- Indagar sobre otros problemas que podrían estar asociados a aquellos que se consultan o a algunas áreas problemáticas que requieran intervención; así mismo,

averiguar las características de su entorno familiar y amical para evaluar sus redes de soporte afectivo.

TERCER PASO: RESPONDER A LAS NECESIDADES, DUDAS E INSEGURIDADES DE LA PERSONA USUARIA

El objetivo de este momento es dar respuesta a las necesidades de atención, dudas e inseguridades de la persona usuaria y facilitar la libre decisión o elección, según sea el caso.

Es el momento también de averiguar sobre la información que tiene la persona usuaria y complementarla, a fin de que pueda hacer un adecuado proceso de análisis de las diferentes opciones. La información que se brinde entonces debe ser precisa, concreta y expresada en un lenguaje claro y sencillo.

Acciones claves:

- Brindar información en un lenguaje claro y con voz cálida.
- Explorar los sentimientos que surgen cuando se coloca en la situación hipotética (¿cómo se sentiría si lo hace?, ¿cómo se sentiría si no lo hace?).
- Identificar el problema, buscar activamente la información necesaria, analizar las ventajas y riesgos, tomando en cuenta la opinión del entorno inmediato y las posibles consecuencias de actuar de una u otra forma. Es muy importante ser veraces, imparciales y evitar influencias de los propios valores o creencias personales.
- Facilitar la toma de decisiones por parte de la persona usuaria, analizando por supuesto los posibles temores u obstáculos.

CUARTO PASO: VERIFICAR LA COMPRENSIÓN DE LA PERSONA USUARIA

El objetivo de este paso es comprobar si la persona usuaria ha entendido la información brindada, si se aclararon sus dudas y temores. También es oportuno para precisar o reforzar alguna información que pudiera quedar pendiente de respuesta.

Acciones claves:

- Preguntas orientadoras para verificar la comprensión.

Preguntas para verificación del cuarto paso de la consejería	Fundamentos de la pregunta
¿Considera que es fácil recordar la conversación sostenida en esta sesión de consejería?	El proveedor puede inferir que la persona usuaria estuvo concentrada en el motivo de su consulta y que asimila la información proporcionada.
¿Podría comentar brevemente la explicación que ha recibido respecto al motivo de su consulta?	Permite al proveedor verificar la comprensión de la información transmitida.
¿Qué aspectos de la sesión considera que ha sido de su mayor satisfacción?	Permite reforzar la información y verificar la utilidad de la sesión.
¿Qué aspectos del motivo de su consulta considera que debemos aclarar o detallar mejor para su tranquilidad?	El proveedor tiene la oportunidad de precisar o aclarar las dudas de la persona usuaria.
¿Usted tiene algo más que comentar que no se haya tratado en esta sesión?	Otorga al consultante la oportunidad de seguir vinculado al servicio y al proveedor mostrar su disponibilidad para apoyar en sus necesidades de salud.

- No interrumpir a la persona usuaria cuando esté hablando.
- Decirle a la persona usuaria que, con toda la información que se ha compartido y la reflexión que ha hecho con su acompañamiento, tiene derecho a tomar una decisión propia; y, sea cual sea la decisión que tome, siempre se cuenta con el apoyo del consejero.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRECC. GRAL. DE INTER. ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA

QUINTO PASO: MANTENER LA RELACIÓN CORDIAL

El objetivo de este paso es reforzar el vínculo establecido con la persona usuaria, estableciendo los mecanismos apropiados para el seguimiento.

Acciones claves:

- Mostrar empatía para conversar con la persona usuaria en una próxima visita.
- En caso de requerir la continuidad de atención de la persona usuaria, derivar a la persona usuaria a otros servicios para la atención especializada.
- Con aceptación de la persona usuaria, involucrarla en otras actividades educativas o grupos de ayuda mutua.
- Programar el seguimiento. Debe detallarse el mecanismo de seguimiento a la persona usuaria, valorando el que sea más adecuado en cada caso, pudiendo ser el uso de tarjeteros, el uso de fichas, visitas domiciliarias, entre otros.

LECCIONES PARA TENER ÉXITO EN LA CONSEJERÍA EN GENERAL

- La cordialidad es un aspecto clave en la percepción de calidad de la persona usuaria, ya que fortalece su confianza y favorece su continuidad en el uso del servicio.
- Ser respetuoso de las expresiones socioculturales de las personas usuarias, ayudar a que se sienta a gusto.
- Alentar explicar sus necesidades, expresar sus preocupaciones y hacer preguntas.
- Dejar que los deseos y las necesidades de la persona usuaria orienten la conversación.
- Estar alerta a las necesidades referidas, como la protección frente a las infecciones de trasmisión sexual (ITS), incluida la infección por el VIH, y el apoyo para el uso del preservativo.
- Conversar con la persona usuaria en un lugar privado, donde nadie más pueda oír u observar.
- Asegurar la confidencialidad, no hablar con otras personas sobre su caso y sobre las decisiones que tome.
- Brindar sólo la información y las instrucciones claves. Usar palabras y/o comunicación de lenguaje inclusivo para personas con discapacidad que la persona usuaria comprenda.
- Referirse a los efectos secundarios, y tomar en serio las preocupaciones de la persona usuaria.
- Comprobar que la persona usuaria ha aprendido durante el proceso de consejería.
- Acordar una cita de seguimiento, es de suma importancia para evitar el abandono al servicio y al método anticonceptivo.
- Invitar a la persona usuaria a regresar cuando quiera y por cualquier motivo.

Toda consejería ha tenido éxito cuando la persona usuaria:

- Siente que obtuvo la ayuda que quería.
- Sabe qué hacer y se siente segura de que puede hacerlo.
- Se siente respetada y apreciada.
- Retorna al servicio cuando lo necesita.
- Y, lo más importante, está satisfecha con la atención recibida.

6.7. CONSEJERÍA EN TEMAS ESPECÍFICOS

El consejero, al inicio de la atención y participación de la persona usuaria, identifica el tema de consejería a ser abordado.

6.7.1. CONSEJERÍA EN SEXUALIDAD

Objetivo: Facilitar a las personas información respecto a un conjunto de comportamientos relacionados con su sexualidad según su curso de vida, desde la afirmación de sus características físicas y biológicas, desarrollo de su personalidad, relaciones de pareja, entre otras necesidades de salud sexual, que les permita disipar

sus dudas y temores, tomar decisiones voluntarias, y que el disfrute de su sexualidad sea segura y libre de riesgos.

La sexualidad nace con el ser humano y le acompaña durante toda su vida. Empieza con el comportamiento natural e instintivo del bebé, continúa en la niñez, pero es en la adolescencia cuando se despierta activamente la sexualidad y que desemboca en la madurez sexual; por lo que, la falta de información sobre sexualidad representa un riesgo constante para que las personas se expongan a los efectos negativos en su salud sexual y reproductiva.

Tanto los adultos como los adolescentes requieren información de fuentes confiables, como son los servicios de salud o por el personal de la salud durante las actividades de salud en la comunidad. En el caso de adolescentes, por encontrarse en un proceso de desarrollo personal y formación de su personalidad, constantemente surgen conflictos con su cambio su imagen corporal. Si en esta etapa no se refuerza información para contrarrestar conceptos erróneos, temores e inseguridades, puede condicionar el incremento de la depresión, drogadicción y relaciones sexuales (RS) sin protección, con el consiguiente aumento de la vulnerabilidad a las ITS, embarazos y otras conductas de riesgo.

En ese contexto de necesidades de salud sexual identificadas, la consejería constituye una de las principales intervenciones de respuesta que ofrecen los servicios de salud y cumplen un rol fundamental para facilitar el acceso a la información y a la atención de salud sexual y reproductiva de calidad.

La consejería se realiza con trato amable, asegurando la privacidad y confidencialidad, con empatía y escucha activa, evitando los prejuicios y cuestionamientos, partiendo que cada persona es única, procurando que se sienta segura de expresar quienes son, lo que desean, lo que sienten y lo que conocen o no sobre su salud sexual y salud reproductiva; esta interacción va a permitir que la persona usuaria reconozca los factores y conductas de riesgo que pueden tener consecuencias adversas para su salud y su vida.

En los servicios de salud, se acogen también las demandas de atención en sexual y reproductiva de las personas con discapacidades físicas, personas con dificultades mentales, poblaciones indígenas, y personas que padecen de enfermedades crónicas que las hacen potencialmente vulnerables para el ejercicio de sus derechos, y están expuestas al embarazo no planificado y las ITS, incluyendo el VIH, así como al abuso, la coerción y la explotación sexual. En el servicio también se tiene en cuenta la comunicación accesible e inclusiva, como lengua de señas y lecto escritura braille, de modo tal que le permita reducir sus riesgos y vulnerabilidades.

6.7.2. CONSEJERÍA PRECONCEPCIONAL

Objetivo: Brindar acciones educativas a la persona usuaria y/o su pareja, y evaluar riesgos médicos en la mujer para identificar y modificar de manera oportuna factores de riesgo, tanto médicos como sociales, con el propósito de mejorar los hábitos saludables y las condiciones para lograr un embarazo favorable, tanto para la madre como para el feto.

El consejero tiene una participación importante para informar y sensibilizar a la mujer/pareja y a su familia respecto a que el embarazo amerita una preparación biopsicosocial junto con actividades preventivas y de educación y promoción para la salud, pues todas estas acciones contribuyen a que la mujer se encuentre en condiciones de menor riesgo para quedar embarazada.

A continuación, se describen las principales estrategias que el consejero promueve en la persona usuaria o a la pareja para asegurar el mejor cuidado preconcepcional:

1. Responsabilidad individual para el autocuidado

Las personas deben ser motivadas y educadas para el autocuidado, en especial para el ejercicio de sus derechos en salud sexual y reproductiva, y para trazar un plan de vida reproductivo, con énfasis en la expectativa de decidir, en el momento que corresponda, si tener hijos o no.

Todas las personas en edad reproductiva deben contar con información para reconocer y actuar de manera proactiva frente a:

- Antecedentes familiares y hereditarios.
- Enfermedades crónicas.
- Riesgo cardiovascular y alteraciones metabólicas.
- Conductas saludables frente a la actividad física y la dieta.
- Alternativas para evitar los embarazos no planeados con el uso de métodos anticonceptivos seguros.
- Riesgos de exposición a agentes teratogénicos o tóxicos.
- Riesgos laborales (biológico, físico, estrés, sobrecarga laboral y otros).

2. Prevención y atenuación de riesgos asociados a hábitos y consumo

Los factores que influyen en las actitudes hacia el cuidado preconcepcional son la edad de la persona, sus hábitos alimenticios, consumo de alcohol, tabaco y de otras sustancias psicotrópicas, su estado de salud, sus prioridades de vida y su historia reproductiva. Desde una perspectiva de salud pública, se debe sensibilizar a los individuos y sus familias para que sean conscientes de que el embarazo amerita una preparación biopsicosocial.

3. Educación preconcepcional

Es de gran importancia que los consejeros comenten con la mujer o su pareja, como mínimo, los siguientes temas: Planificación de la familia, espaciamiento de los hijos, prevención del embarazo, evaluación del peso óptimo, estado de inmunización contra enfermedades infecciosas, importancia de la atención prenatal temprana y la detección oportuna de los factores de riesgo cardio metabólicos, entre otros aspectos.

La información recibida permite al consejero programar las siguientes sesiones de consejería en el servicio o derivar a consulta preconcepcional para detección oportuna y manejo de condiciones médicas que podrían convertirse en riesgo durante la gestación, agravarse como consecuencia de ella y afectar la salud o la vida de la madre y del feto.

6.7.3. CONSEJERÍA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Objetivo: Facilitar información a las personas sobre la amplia gama de métodos anticonceptivos temporales y definitivos con la finalidad que la persona usuaria elija un método anticonceptivo que más se acomode a sus necesidades reproductivas, decidir el número de hijos y el momento idóneo para tenerlos, así como para limitar el número de hijos cuando considere haber logrado el ideal reproductivo.

La consejería en planificación familiar constituye una de las principales demandas en salud sexual y reproductiva. Si la persona usuaria requiere un método anticonceptivo, se le apoya para que elija el método más apropiado para ella o para la pareja; se refuerza la información sobre la seguridad, eficacia y duración de la protección anticonceptiva de cada uno de los métodos, así como de sus características: Indicaciones, beneficios y/o limitaciones, necesidades de seguimiento, signos de alarma, buen uso y formas de almacenamiento seguro del insumo.

En el caso de que la persona opte por algún método desde la primera consulta, este puede ser administrado conforme a lo dispuesto en la NTS N° 124-2016/MINSA-V.01: Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, aprobada por Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, o la que haga sus veces.

Para la consejería se utiliza el modelo de los 5 pasos descrito en el subnumeral 6.6 y lo detallado en las recomendaciones contenidas en el Anexo 1, explicando que la información solicitada es utilizada para ayudarle a elegir el método anticonceptivo más adecuado.

Para facilitar la elección del método anticonceptivo:

- Indague qué conocimiento tiene la persona usuaria sobre los métodos anticonceptivos.
- Explique a la persona usuaria cuáles son los métodos anticonceptivos, características y mecanismo de acción.
- Explique a la persona usuaria la forma de uso del método, de preferencia, utilizando un material de apoyo.
- Brinde a la persona usuaria información sobre la seguridad anticonceptiva (eficacia).
- Aclare conceptos, dudas y temores.
- Explique a la persona usuaria sobre posibles efectos colaterales.
- Señale a la persona usuaria los signos y síntomas de alarma ante los cuales debe consultar.
- Brinde a la persona usuaria información sobre el retorno de la fertilidad al suspender el método anticonceptivo.
- Brinde a la persona usuaria información sobre la necesidad de la doble protección para evitar las ITS, incluidas sífilis, HB, VIH y el Virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTLV-1), dado que este puede provocar transmisión vertical de la madre infectada a su hijo durante la gestación, parto o lactancia materna.
- En caso de identificarse contraindicaciones para el uso del anticonceptivo elegido por la persona usuaria, se le orienta a escoger otro método.

Consejería exitosa

Una buena consejería ayuda a la persona a elegir y utilizar los métodos de planificación familiar que más les conviene. La consejería se adapta a cada persona usuaria.

Tipos de usuarios	Tareas de consejería habituales
Personas usuarias que regresan sin problemas.	Proporcione más suministros o realice el seguimiento habitual y pregúntele amablemente cómo le va con el método anticonceptivo.
Personas usuarias que regresan con problemas.	Entienda el problema y ayude a resolverlo, ya sea que se trate de efectos secundarios, problemas para usar el método, falta de cooperación de la pareja u otro problema que requiera ser atendido por otras especialidades.
Personas usuarias nuevas con un método en mente.	• Compruebe si lo que conoce la persona usuaria es correcto. • Evalúe si cumple condiciones médicas para utilizar el método elegido. • Utilidad del método anticonceptivo y manejo de los efectos secundarios.
Personas usuarias nuevas sin un método en mente.	• Analice la situación, sus planes y lo que considera importante de un método anticonceptivo. • Informe a la persona usuaria los métodos que podrían convenirle. Si fuera necesario, ayude a tomar una decisión. • Brinde instrucciones sobre cómo utilizar el método anticonceptivo e informe cómo se pueden manejar los efectos secundarios.

Si la persona usuaria decide no practicar la anticoncepción:

- Infórmele sobre los riesgos para su salud asociados al embarazo, si fuera el caso.
- Asegúrese que comprenda los riesgos de un embarazo.
- Evalúe condiciones psicológicas y sociales.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRECC. GRAL. DE INTER. ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA

- Solicite que regrese si cambia de parecer.
- En todas las situaciones que acuda al servicio debe descartarse acciones de violencia por parte de la pareja u otros.
- Infórmele acerca de otros servicios que pudiera necesitar, como la consejería preconcepcional, atención prenatal, prevención de cáncer y otros.
- De considerar necesario, derive a la persona usuaria para atención en otros servicios psicología, servicio social u otros que garanticen un soporte a las decisiones.

Condiciones médicas que hacen riesgoso el embarazo

Existen algunas condiciones médicas en las cuales el embarazo no planificado puede significar un riesgo de salud para las mujeres, por lo que deben recibir la más amplia información para tomar decisiones informadas y prevenir el embarazo con métodos temporales o definitivos. Entre las principales condiciones de riesgo para el embarazo tenemos:

- Cáncer de mama.
- Cáncer de ovario.
- Cáncer de endometrio.
- Hipertensión arterial severa.
- Valvulopatía cardiaca complicada.
- Cardiopatía isquémica.
- Accidente cerebro vascular.
- Esquistomatosis hepática.
- Diabetes insulinodependiente.
- Anemia falciforme.
- Cirrosis hepática grave.
- Tumores malignos hepáticos.
- Cesárea anterior 2 o más veces.
- Antecedentes de cesárea corporal.
- Antecedentes de morbilidad materna extrema.

Cuando la persona usuaria desea continuar con el mismo método o la posibilidad de cambiar, esta decisión parte de la necesidad de la misma persona usuaria (Anexo 2).

En el caso de que la persona usuaria opte por el dispositivo intrauterino o el implante subdérmico, debe firmar el consentimiento informado y la solicitud para la inserción correspondiente, los cuales se encuentran especificados en la NTS N°124-2016/MINSA-V.01: Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, aprobada por Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, o la que haga sus veces. En caso de que la persona usuaria que no sepa firmar, se debe imprimir su huella digital en señal de conformidad, conforme al artículo 24 de Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, aprobado por Decreto Supremo N°027-2015-SA.

Consejería en Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)

A. Consideraciones para la consejería en AQV femenina

Es un método anticonceptivo permanente, que se realiza mediante una intervención quirúrgica electiva de complejidad intermedia, cuyo objetivo es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo al nivel de la trompa con el fin de evitar la fertilización. Por lo tanto, resulta necesario tomar ciertas consideraciones que se detallan a continuación:

1. Asegúrese que la usuaria conozca las características del método para que la elección sea libre e informada.
2. En la consejería, se le brinda la información necesaria y se absuelven sus dudas poniendo especial consideración en las pacientes que sufren enfermedades crónicas y en quienes un embarazo podría poner en riesgo su vida.
3. Ofrecer información amplia sobre el procedimiento y que puede ser realizado en diferentes momentos, como en el post parto, intra cesárea y de intervalo.

4. Tomar el tiempo necesario para informar y responder a las inquietudes de la usuaria, aclarar conceptos erróneos y prejuicios que pueda tener con relación al método.
5. Las usuarias que soliciten este método deben tener, por lo menos, 3 sesiones de consejería: La general, la específica para AQV, y la tercera después de las 72 horas para la firma del consentimiento informado y autorización de la intervención para la AQV, conforme a lo dispuesto por la NTS N° 124-2016/MINSA-V01: Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, aprobada por Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, o la que haga sus veces.
6. En caso no sepan firmar, se procede conforme al Reglamento de la Ley N° 29414, aprobado por Decreto Supremo N°027-2015-SA.
7. El consentimiento informado debe ser leído por la persona usuaria conjuntamente con el consejero, analizando detenidamente y verificando su comprensión en cada uno de los puntos (Considerar contar con documento con lecto escritura accesible para personas con discapacidad).
8. Entregar a la persona usuaria una copia de la solicitud de intervención firmada y el original queda en la historia clínica como autorización para el procedimiento y documentar que la opción fue informada y voluntaria.
9. La persona usuaria puede cambiar su decisión en cualquier momento previo a la intervención quirúrgica a pesar de haber firmado el consentimiento informado y la autorización de intervención. Su decisión queda registrada en la historia clínica.
10. La persona usuaria debe conocer cuáles son los establecimientos de salud que la pueden atender en caso existiera una complicación.

B. Consideraciones para la consejería en la AQV masculina

1. Hay que destacar que se trata de un procedimiento quirúrgico definitivo; por lo que, es preciso aclarar conceptos erróneos relacionados con el procedimiento, suministrando información correcta en forma sencilla clara y precisa para facilitar la comprensión y la toma de decisión.
2. Informar a la persona usuaria que su comportamiento sexual no es afectado con la intervención, considerando que una preocupación constante en el varón es el efecto que la vasectomía puede tener sobre su actividad sexual.
3. Los usuarios que soliciten este método deben tener, por lo menos, 3 sesiones de consejería: La general, la específica para la AQV, y la tercera después de las 72 horas para la firma del consentimiento y autorización para la AQV, conforme a lo dispuesto en la NTS N° 124-2016/MINSA-V01: Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, aprobada por Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, o la que haga sus veces.
4. En el caso de personas que no saben firmar, se procede conforme al Reglamento de la Ley N° 29414, aprobado por Decreto Supremo N°027-2015-SA.
5. El consentimiento informado debe ser leído por la persona usuaria conjuntamente con el consejero, analizándose detenidamente y verificando su comprensión en cada uno de los puntos (Considerar contar con documento con lecto escritura accesible para personas con discapacidad).
6. Entregar a la persona usuaria una copia de la solicitud de intervención firmada y el original queda en la historia clínica como autorización legal para el procedimiento y documentar que la opción fue informada y voluntaria.
7. Hay que recordar que la persona usuaria puede cambiar su decisión en cualquier momento previo a la intervención quirúrgica, aunque haya firmado el consentimiento informado y autorización de intervención.
8. La persona usuaria y su pareja deben estar informados sobre el uso del condón u otro método anticonceptivo en el periodo postoperatorio de la vasectomía, hasta contar con el resultado negativo del recuento de espermatozoides y/o que hayan transcurrido 3 meses luego de la intervención, ya que puede producirse un embarazo por falta de protección durante este periodo.

Consentimiento informado para la AQV

Para toda intervención en AQV femenina o masculina se requiere el consentimiento informado.

El consentimiento es la certificación en un formato escrito o con lectoescritura accesible, que acredita que la persona usuaria ha recibido y entendido la información facilitada sobre un procedimiento quirúrgico. Es un requerimiento ético y legal requerido antes de cualquier intervención.

El consentimiento informado tiene validez si la persona usuaria:

- Dispone de una información completa.
- Comprende la información adecuadamente.
- Se encuentra apta para tomar la decisión.

Características asociadas a una decisión sólida para la persona usuaria

- Ha logrado o excedido el tamaño de familia deseada.
- Expectativas realistas.
- Es emocionalmente estable.
- Sentido de seguridad en la decisión que ha tomado.
- Un deseo real de terminar su fecundidad.
- Está bien informada sobre el método.

Señales de advertencia de posibilidad de arrepentimiento posterior a la AQV

- Persona muy joven (menores de 25 años, por el alto riesgo de arrepentimiento).
- Inseguridad respecto al número de hijos.
- Presión por parte de otras personas.
- Inestabilidad en la relación conyugal.
- Tensión emocional temporal.
- Conflicto o duda sin resolver.
- Motivos económicos.
- Interés excesivo en las posibilidades de reversión de la operación.
- Decisión tomada bajo la presión de un evento relacionado con la fecundidad (parto o aborto).

6.7.4. CONSEJERÍA EN ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA

Objetivo: Brindar información a la persona usuaria sobre la anticoncepción oral de emergencia (AOE) para prevenir el embarazo durante un período corto después de una RS no protegida y promover el uso de un método regular de planificación familiar

El AOE es parte del derecho sexual y reproductivo de la mujer, su uso principalmente es para prevenir el embarazo en RS no protegida. Sin embargo, durante la consejería se destaca que la AOE no debe usarse reiteradamente ni de manera continua, como su nombre lo indica es una opción de emergencia. No reemplaza al uso continuo de otros métodos anticonceptivos.

La AOE se puede requerir en las siguientes circunstancias, por lo que es importante la privacidad y confidencialidad durante la consejería:

- Después de una RS sin protección.
- Después de una RS contra su voluntad (violación sexual).
- No se usa regularmente un método anticonceptivo.
- Uso incorrecto o falla del método anticonceptivo empleado en la RS, como:
  - Se rompió o se deslizó el condón.
  - Si el DIU ha sido expulsado.
  - Se olvidó de tomar 2 días o más sus anticonceptivos orales.
  - Si se ha retrasado más de 2 semanas en recibir su método anticonceptivo de depósito inyectable trimestral o más de 3 días del inyectable mensual.
  - Mal uso de los métodos de abstinencia periódica.

La administración del AOE se encuentra establecida en la NTS N°124-2016/MINSA-V.01: Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, aprobada por Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, o la que haga sus veces. Asimismo, los medicamentos

hormonales utilizados como AOE se encuentran también considerados en el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, aprobado por Resolución Ministerial N° 633-2023/MINSA, o el que haga sus veces.

EL AOE debe tomarse cuanto antes tras la RS sin protección, pues así es más efectivo. Lo ideal es tomarlo en las siguientes 24 horas a la RS. Aunque su efecto se prolonga hasta las 72 horas post RS sin protección, su eficacia va disminuyendo conforme pasa el tiempo.

La consejería en AOE proporciona también una oportunidad importante para que la mujer empiece a utilizar un método regular de planificación familiar. Si en el momento no desea información sobre los métodos anticonceptivos de uso regular, se ofrece programar una próxima sesión.

Información que se debe dar a la persona usuaria:

- Explique cómo actúa en el organismo y que no es abortivo.
- Indique la forma correcta de su uso y que debe tomarse lo más pronto posible ya que la eficacia puede disminuir cuanto más demore en su administración.
- Recomiende que no tome ninguna dosis extra, ya que ello podría aumentar los efectos colaterales, pero no aumentaría la efectividad.
- Describa cuáles son los efectos colaterales comunes, recuerde que la consejería previa sobre los posibles efectos ayuda a las mujeres a que puedan tener una mejor tolerancia.
- Explique que la dosis necesita ser repetida si la persona usuaria vomita dentro de las 2 horas después de haberla tomado.
- Asegúrese que la persona usuaria comprenda que la AOE no la protege de un embarazo si mantiene contacto sexual sin protección en los días o semanas siguientes a la toma.
- Informe que el periodo menstrual puede llegar unos pocos días antes o más tarde de lo esperado. Explique que, si su periodo menstrual se retrasa más de una semana, debe regresar al establecimiento de salud para descartar un embarazo.

Ver el Anexo 3 que contiene las preguntas más frecuentes sobre la AOE.

6.7.5. CONSEJERÍA DURANTE EL EMBARAZO Y EN EL POST PARTO

Objetivo: Fortalecer las acciones positivas para el adecuado cuidado en el embarazo, tanto físicas como psicológicas, identificación de factores de riesgo, preparación para la atención de parto, post parto y la adaptación a una nueva situación familiar.

Para las mujeres embarazadas y puérperas, los cuidados de su salud y la de su niño son primordiales, por lo que la consejería es una actividad integral que se brinda durante el periodo prenatal, el periodo post parto, antes del alta hospitalaria o en el hogar durante las visitas domiciliarias.

El consejero cuenta con información actualizada sobre la normatividad relacionada a salud sexual y reproductiva para abordar los siguientes aspectos:

- Cuidados generales de la salud: Higiene, actividad física, consecuencias de la ingesta de tabaco y alcohol.
- Fortalecimiento del vínculo afectivo y el rol de padres, cuidados en el embarazo, reconocimiento de los signos de alarma, administración de vacunas.
- Alimentación saludable y cuidados nutricionales (suplementación y prevención de anemia) durante el embarazo y después del parto.
- Sexualidad y embarazo.
- Prevención de infecciones en general.
- Salud mental, prevención y atención de la violencia.
- Importancia del parto institucional, promoción del parto con acompañante, disponibilidad de casa materna, ventajas del alojamiento conjunto y vínculo afectivo.
- Preparación para la lactancia y lactancia materna exclusiva.

- Adopción de métodos de planificación familiar de larga duración en el post parto inmediato y mediato.

El consejero tiene presente que las mujeres durante el embarazo y puerperio a menudo presentan cambios físicos y emocionales; en algunos casos, ansiedad, preocupándose no sólo por su salud y la de su bebé, sino también por aspectos de su sexualidad.

Asimismo, con la finalidad de contribuir a la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, sífilis y de la HB, es importante que el consejero brinde información a la gestante sobre la existencia de pruebas rápidas para la detección de VIH, sífilis y HB, y, previa consejería y consentimiento informado, pueden ser aplicadas para la detección temprana; de resultar prueba positiva a cualquiera de estas infecciones, la gestante o puérpera y su recién nacido (RN) reciben tratamiento gratuito.

El puerperio es un periodo muy especial en la vida de la mujer. Es un momento que supone una carga emocional muy importante pero también de gran tensión ante la adaptación a la nueva situación familiar. El organismo materno está nuevamente en proceso de cambio hacia una recuperación al estado previo a la gestación o, bien, adaptándose a un nuevo proceso fisiológico que es la lactancia materna; por lo que, resulta preciso brindar información sobre la importancia del espaciamiento óptimo entre nacimientos, idealmente de 3 a 5 años.

Momento para brindar la consejería en anticoncepción.	El periodo prenatal es ideal para brindar la consejería a la gestante, ya que tiene tiempo suficiente para tomar su decisión. Considerando que existen factores de riesgo en algunas mujeres y que un embarazo pondría en peligro su salud y su vida, es importante que, durante las atenciones prenatales, se ofrezca consejería para optar por un método de larga duración o un método definitivo antes del alta. Idealmente, se debería lograr que participe la pareja. Si la gestante tiene factores de riesgo que la ponen en alta vulnerabilidad de complicaciones en el parto y futuros embarazos y cumple con las consideraciones señaladas para la AQV en la NTS N°124-2016/MINSA-V.01: Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, aprobada por Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, o la que haga sus veces, puede firmar el consentimiento informado (considerar contar con material con lectoescritura accesible para personas con discapacidad) y autorizar el procedimiento para ser realizado durante la cesárea o después del parto antes del alta.
¿Cuándo iniciar los anticonceptivos tras el parto? - Métodos anticonceptivos sugeridos.	El período de infertilidad tras el parto es muy breve. En las mujeres que no dan de lactar, la ovulación puede ocurrir durante la tercera semana del puerperio; por ello, se debe establecer la utilización de algún método anticonceptivo antes del reinicio de las RS o en el post parto inmediato. Los métodos anticonceptivos para las mujeres que están amamantando son aquellos que no interfieren con la lactancia, no afectan la calidad ni la cantidad de la leche materna. Métodos anticonceptivos en el puerperio: • Métodos de barrera. • Anticonceptivos hormonales sólo de progestágeno. • Implantes subdérmicos. • Dispositivos intrauterinos (DIU) es un método altamente eficaz, siempre es importante conocer las

	limitaciones para su uso, las condiciones generales y específicas de cada puérpera. • Método definitivo como la AQV, es preciso que la decisión sea meditada y nunca supeditada a la sobrecarga emocional para evitar arrepentimientos.
Consideraciones o cuidados.	• Se debe considerar el estado emocional de la usuaria y respetar la decisión de conversar o no sobre la posibilidad de usar anticonceptivos. • En caso de que la puérpera acepte la consejería, se recomienda que sea ofrecida también a la pareja. Es importante reforzar los métodos anticonceptivos más efectivos, a fin de prolongar el tiempo intergenésico y evitar el segundo embarazo. • ¿Cuándo iniciar las RS después del parto? No hay un límite definido, es el sentido común de la pareja, basado en el estado de la madre quien señale el momento de reiniciar las RS. Es la propia mujer quien perciba normalidad de su aparato genital para reiniciar las relaciones; pueden iniciarse cuando la mujer se encuentre suficientemente cómoda para ello.

Acciones de seguimiento a puérperas que NO optan por un método anticonceptivo.

Las puérperas que, al egreso hospitalario NO toman la decisión de utilizar un método anticonceptivo moderno y cuenten con factores de riesgo reproductivo, antecedentes de morbilidad materna extrema, cuyas condiciones clínicas la colocan en alta vulnerabilidad, deben contar con un registro y plan de seguimiento con el objetivo de ampliar la información sobre su situación particular que le permita a la mujer y/o pareja optar por un método anticonceptivo moderno y espaciar o limitar futuros embarazos.

6.7.6. CONSEJERÍA EN ATENCIÓN DEL PARTO CON PERTINENCIA CULTURAL

Objetivo: Brindar información a la gestante y pareja o familia sobre las ventajas y procedimientos en la atención del parto con pertinencia cultural y parto vertical, a fin de que la gestante pueda tomar una decisión informada sobre la modalidad en que desea ser atendida en el momento del parto, así como los usos y costumbres culturales que favorecen su atención y recuperación.

Todas las mujeres que acuden a la atención prenatal reciben información sobre atención del parto con pertinencia cultural y parto vertical; para tal efecto, el proveedor de salud debe tener dominio de los criterios de inclusión y exclusión establecidos en la NTS N°121-MINSA/DGIESP-V.01: Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el Marco de los Derechos Humanos con Pertinencia Intercultural, aprobada por Resolución Ministerial N° 518-2016/MINSA, o la que haga sus veces.

El consejero debe establecer relaciones respetuosas, horizontales y empáticas siempre. Si la gestante cumple los criterios de inclusión, es candidata a la elección de parto vertical y recibe información completa sobre las ventajas y procedimientos a realizar.

Si la gestante no cuenta con atenciones prenatales previas, se le debe explicar el proceso del parto para disminuir el temor a lo desconocido; en lo posible, mostrarle los ambientes físicos del establecimiento de salud donde será atendida, así mismo presentar al equipo de salud que le brinda la atención.

Para asegurar la atención del parto con pertinencia cultural, el consejero informa a la gestante que:

- Puede estar acompañada de su esposo/pareja, familiar, persona de su confianza o quien ella decida; si el consejero no hablara el mismo idioma, se procura usar un intérprete para una mejor comunicación y entendimiento de los mensajes.

- El procedimiento a seguir una vez que haya ingresado para la atención de parto.
- La firma de consentimiento informado para algún procedimiento adicional a la atención del parto, sólo de ser necesario. De ser posible, el contenido del citado documento es traducido y/o leído en un lenguaje comprensible para la gestante.
- Se respetan sus prácticas habituales de su cultura relacionadas a la atención del parto (creencias, idioma y costumbres), que no sean nocivas para su salud.
- Se le permite la ingesta de alimentos y líquidos preparados o infusiones que favorezcan el trabajo de parto de acuerdo con sus costumbres.
- En el momento del parto, se respeta el uso de ropa según sus costumbres o se le ofrece ropa adaptada para el tipo de atención que se le brinda.
- En el servicio se le ofrecen distintas posiciones para la atención de su parto y a las que ella se adecue: Posición de cuclillas, posición de rodillas, posición sentada, posición parada o sostenida de una soga y posición en 4 puntos.
- Se le permite, según sus preferencias, llevarse la placenta, de acuerdo con sus costumbres luego del período expulsivo, salvo que constituya un factor de riesgo, como es la presencia de VIH, ITS, entre otras.

6.7.7. CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA

Objetivo: Proporcionar información a la madre sobre los beneficios de la lactancia materna (LM) exclusiva necesarios para el crecimiento y desarrollo de su bebé, y su uso como método de planificación familiar durante los primeros 6 meses posteriores al parto.

El consejero informa a la gestante o puérpera sobre los beneficios de la LM para la salud del niño y de la madre, la familia y la sociedad; recomienda que los niños inicien la LM en la primera hora del nacimiento y sean amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida. Informa que la leche materna está llena de inmunoglobulinas y protege al RN contra las infecciones y reduce la mortalidad neonatal, proporciona nutrientes necesarios en calidad y cantidad para el crecimiento y desarrollo óptimo.

Sin embargo, el consejero también conoce que hay excepciones para la LM, como es el caso de niños expuestos al VIH o al HTLV-1, donde la recomendación general es evitar la LM, siendo la alternativa el uso de alimentación infantil segura, como los sucedáneos de leche materna (SLM) para prevenir la transmisión del virus.

Asimismo, en la etapa del puerperio, la responsabilidad de criar a un hijo ocasiona sentimientos de temor y ansiedad en las madres. Si bien es cierto ellas pueden reconocer los beneficios de la LM; sin embargo, no están exentas de preocupaciones, especialmente en las primíparas y las que han tenido alguna experiencia anterior negativa, lo que puede perturbar la lactancia.

Por estas consideraciones, la consejería en LM forma parte de las atenciones prioritarias y un desafío para todo el personal de la salud para lograr una LM exitosa y una experiencia gratificante para la madre y su hijo.

En los servicios de consejería, es frecuente abordar las dudas e inseguridades respecto a:

- No saber amamantar; si se tiene suficiente leche para alimentar a su hijo, más aún si hay más de uno; no saber identificar el llanto, si el bebé quedó saciado o está con hambre. La consejería puede responder a estas necesidades dando información y asistencia sobre las técnicas de amamantamiento, el incremento progresivo en la producción de la leche; así mismo, los padres tienen que aprender a aceptar la nueva convivencia con el bebé y manejar la dependencia que ellos generan. Es importante la presencia y apoyo, no sólo de parte de la pareja, sino también el apoyo familiar para entender que amamantar lleva tiempo y requiere de práctica. Brindar, así mismo, explicación sencilla sobre las ventajas del calostro, que es reconocido como la primera vacuna que protege al RN de gérmenes y alergias, y que la cantidad de calostro es suficiente para cubrir las necesidades de su bebé.
- Inseguridades sobre el retorno a laborar. Informar sobre las normas que protegen a la madre lactante, los períodos de descanso por LM, los horarios destinados a la LM cuando tenga que retornar a su sede laboral.

- Razones de índole personal sobre lo estético, ganancia de peso materno, tamaño y cambio en las mamas. Explicar a la madre que la LM ayuda a disminuir la grasa corporal y a reestablecer el peso que tenía antes del embarazo, así mismo que los cambios de las mamas son normales (aumento de tamaño y sensibilidad, mayor tamaño y pigmentación de la areola y del pezón) y que el tamaño de las mamas no tiene relación con la capacidad de producir leche ni que la lactancia los deforma. Explicar a la madre y a la pareja que la secreción abundante de leche ocurre generalmente al tercer día postparto; y, que, en algunos casos, la bajada de la leche se retrasa por factores externos: Cesárea, estrés, analgesia obstétrica, retención placentaria, entre los más frecuentes.
- La madre debe procurar una alimentación balanceada y saludable, alimentos de origen animal, como fuente de hierro, frutas y verduras, uso de sal yodada y consumir alimentos energéticos. Asegurar en el post parto la suplementación con sulfato ferroso y ácido fólico.
- En la higiene de las mamas, se debe evitar el uso de jabones, cremas y colonias porque afectan la grasa natural de los pezones. Recomendar sostenes que no ajusten las mamas, así como ropa ligera y cómoda.
- ¿Qué hacer para continuar con la LM ante las horas de ausencia por motivos de trabajo? De ser parte de las preocupaciones de la madre, explicar las formas de extracción, conservación y administración de la leche. Debemos recordar que los primeros 6 meses del bebé deben ser LM exclusiva, luego se complementan con sus alimentos y se continua con la lactancia, de preferencia, por un periodo de 2 años.
- Entre otros beneficios importantes para la madre es que la LM funciona como método de planificación familiar, aunque sus tasas de eficacia son menores que los métodos anticonceptivos modernos y deben cumplirse las siguientes condiciones:

  1. Lactancia exclusiva a libre demanda, promedio de amamantar de 10 a 12 veces al día durante el día y la noche, con un intervalo no mayor a 4 horas durante el día y 6 horas durante la noche.
  2. La persona usuaria se mantenga en amenorrea.
  3. La persona usuaria se encuentre dentro de los 6 meses post parto.

6.7.8. CONSEJERÍA EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA POR INDICACIÓN TERAPÉUTICA DEL EMBARAZO MENOR DE 22 SEMANAS CON CONSENTIMIENTO INFORMADO

Objetivo: Poner a disposición de las mujeres, cuyo diagnóstico médico evidencie que el embarazo pone en riesgo su vida y su salud, la posibilidad de interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, bajo el consentimiento informado de la gestante.

Los profesionales de la salud en cumplimiento de sus funciones tienen la misión de brindar a la familia la mejor atención de salud basada en la evidencia científica y con contenido ético, colaborando con su educación y acompañando los procesos de cuidado y promoción de actitudes saludables. En el embarazo, sus esfuerzos están centrados primordialmente en proteger la vida y la salud de la gestante y del feto. Sin embargo, hay condiciones que un embarazo pone en riesgo la vida y la salud de la madre. En dichos casos y cuando el diagnóstico médico evidencie dicha condición en la gestante, y cuando sea el único medio para salvar la vida o para evitar en su salud un mal grave o permanente, se considera como una alternativa la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, la misma que debe contar con consentimiento informado de la gestante.

Esta prestación de salud se realiza en el marco de la "Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal", aprobada por Resolución Ministerial N°486-2014/MINSA o la que haga sus veces.

6.7.9. CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR

Objetivo: Contribuir al reconocimiento de actitudes y conductas violentas en el ámbito familiar, con énfasis en mujeres en situación de vulnerabilidad por carecer de independencia económica, escaso empoderamiento y desconocimiento para el ejercicio de sus derechos y libertades, entre otros; de ocurrir violencia, facilitar el acceso oportuno a servicios de salud para atención física y psicológica y reducir la prevalencia y severidad de los daños causados a su salud.

Considerando que la violencia es un problema de salud pública, en nuestro país y la mayor afectación se produce a mujeres, se aprueba la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y, posteriormente, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°009-2016-MIMP, así como el Texto Único Ordenado de la Ley N°30364, aprobado con Decreto Supremo N°004-2020-MIMP.

En este contexto, el consejero conoce y aplica la normatividad existente sobre violencia, incide en las medidas de prevención y pone en conocimiento de los procesos de atención cuando ello ocurre. Asimismo, explica los tipos de violencia que la persona usuaria pueda reconocer antes de que esto ocurra, o identificar si ya se encuentra inmersa en alguna de ellas; violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial.

La violencia económica puede pasar desapercibida debido a que no deja un rastro tan evidente como las agresiones físicas.

En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos y estos vivan con ellas, la limitación de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión de sus obligaciones alimentarias por parte de la pareja, se considera como una forma de violencia económica o patrimonial contra la mujer y los hijos.

Atención a las mujeres víctimas de violencia

El primer paso para prevenir y romper con la violencia es conocer y comprender cómo funciona el círculo de la violencia en el que pueden estar muchas mujeres sin darse cuenta. No actuar a tiempo podría causar daños irreparables en su salud y, en un caso extremo, la muerte.

El círculo de la violencia

Fase 1: Acumulación de tensión.	Se caracteriza por conflictos en la relación de pareja. La violencia puede expresarse con palabras descalificadoras, hirientes y, a veces, con golpes o empujones. La mujer no alcanza a comprender la situación de violencia y la justifica, considera que de esa manera va a complacer a su pareja y a calmarlo. También piensa que ella provoca el enojo de su pareja.
Fase 2: Explosión o agresión.	Es el resultado de la tensión acumulada. Se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor y descarga sus tensiones. Estalla la violencia de varios modos: Física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. La mujer siente miedo y, por lo general, consulta a alguna amiga o familiar y es el momento para buscar ayuda. Después del incidente violento, es posible que el mismo agresor cure las lesiones de su víctima o la lleve al establecimiento de salud. argumentando que se trató de un "accidente".
Fase 3: Arrepentimiento, reconciliación o luna de miel.	Después de los episodios violentos, el agresor cambia de actitud: Pide perdón, se muestra amable, cariñoso y

	promete que no vuelve a repetirse, pero la situación puede volver a ocurrir. Así se inicia el ciclo nuevamente, la tensión se acumula y la violencia se incrementa. Se genera una sensación de no salida y de aceptación de la violencia. En este caso, las agresiones son cada vez más violentas.

Para la consejería se aplica el método de los 5 pasos, en base al ciclo de la violencia:

Paso 1: Conexión y empatía con la víctima de violencia.

- Tener en cuenta que este primer contacto es vital para la víctima de violencia, requiere una conexión especial de confianza y empatía con la persona que lo atiende; por lo que, el lenguaje verbal, los gestos corporales y la expresión facial del consejero son relevantes al inicio y en todo el proceso de la consejería para romper la barrera de la vergüenza, inseguridad, culpabilidad y desconfianza.
- Procurar un ambiente seguro, privado y con comodidad física para la víctima de violencia, así como mantener la confidencialidad en el manejo de la información.
- Concentrar la atención en las necesidades y preocupaciones de las víctimas de violencia; la acogida cálida y una escucha activa es la manera de recibirles, no juzgar, ni culpar y menos censurar.
- Mostrar en todo momento un tono de voz gentil, empático, hay que explicar que estamos para escucharle, orientarle y ayudarle a reflexionar para que tome decisiones informadas sobre el problema.
- Mantener una escucha activa y de comprensión de la situación por la que pasa la víctima, ponerse en su lugar; para ello, estimular el diálogo y confianza con las frases *"comprendemos cómo se siente", "estamos para escucharle y ayudarle".*
- Tratar de identificar y visibilizar los aspectos positivos de la víctima, expresándole, *"eres una persona valiosa",* lo cual refuerza la valentía de la víctima por buscar la consejería ya que es un primer paso para romper su silencio.
- Explicar que existen mecanismos de atención de salud, denuncia, protección física, asesoría legal, soporte psicológico y acompañamiento social por parte de las instituciones del Estado que pueden ser usados para atender su problema de violencia.
- Evitar la revictimización en todo el proceso de la atención.

Paso 2: Identificar los factores de riesgo y/o características del problema de violencia.

Una vez establecido un diálogo fluido y de confianza con la persona víctima de violencia:

- Identificar los factores protectores y los riesgos existentes que pueden ser retomados para abordar objetivamente el problema de violencia.
- Explorar con la víctima de violencia información sobre datos personales, laborales, así como de la pareja, es decir, todos aquellos elementos que puedan contextualizar el entorno socioeconómico y cultural con la que interactúa.
- Hay que considerar que el primer paso para enfrentar la situación de la violencia es que la víctima decida hacerlo; por ello, es importante valorar en qué nivel de autonomía personal se encuentra, qué nivel de información o manejo tiene de sus derechos, cuánto conoce sobre los mecanismos de protección y si sabe cómo usarlos.
- Indagar por el riesgo que puede incrementar el daño de la violencia a la víctima, si la persona que agrede cuenta con arma, ingiere drogas, alcohol; si las características de la casa le permiten ser auxiliada o escuchada.
- Permitir, en todo momento, la expresión de los sentimientos y emociones de la víctima (llanto, silencios o ira), realizando contención emocional, en caso de necesidad.
- Indagar con la víctima sobre los riesgos con sus hijos o dependientes; si la persona

agresora acostumbra a golpearlos o amenazarlos; cómo se sienten o qué tipo de reacciones, comportamiento o conductas tienen sus dependientes.

- Evaluar con la víctima de violencia sobre los riesgos potenciales y diversas manifestaciones que puede ejercerse contra ella. Ejemplifica que la violación sexual puede conllevar a un embarazo no planificado, o a una ITS-VIH/SIDA; que el incremento de la violencia física puede generarle alguna fractura, heridas abiertas, puede tener riesgo de tétanos, infección; que la violencia psicológica vulnera su autoestima, le genera depresión, tristeza; entre otros.

Paso 3: Responder a las necesidades de atención de la víctima de violencia.

Una vez identificadas las necesidades de la víctima de violencia:

- Explicar que, existe el "Protocolo de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer - CEM y los Establecimientos de Salud- EE.SS. para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364, y personas afectadas por violencia sexual", aprobado por Decreto Supremo N° 008-2019-SA.
- Informar a la víctima que los establecimientos de salud brindan en forma gratuita la prevención, atención y recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia, así como a los integrantes de su grupo familiar; la atención, de ser necesaria, incluye atención hospitalaria gratuita y otras actividades necesarias para la recuperación de su salud. Si la víctima no contara con un seguro, se le informa cómo gestionar su afiliación en el Seguro Integral de Salud.
- Informar a las víctimas de violencia, que todos los afectados reciben atención independientemente si cuentan o no con su documento nacional de identidad, carné de extranjería u otro documento de identificación.
- Explicar que todos los establecimientos de salud cuentan con un kit para la atención de casos de violación sexual, que forma parte del paquete de servicios en los establecimientos de salud para la atención adecuada, oportuna y rápida a las víctimas. Su provisión es gratuita.
- Informar que, en situaciones especiales, cuando requieren protección, el Juzgado de Familia dispone las medidas necesarias y supervisa el cumplimiento de dichas medidas en coordinación con las entidades pertinentes.
- Explicar de manera clara a la víctima de violencia la ruta a seguir para la atención integral, utilizando el flujograma de atención correspondiente. Indicar claramente los procesos de atención en las instituciones públicas, como el Centro de Emergencia Mujer (CEM), en la comisaría a cargo de la Policía Nacional del Perú, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, entre otros.
- Informar a la víctima que existe una red de apoyo familiar y comunitario para mejorar la seguridad de las víctimas y el grupo de familia en todos los casos.
- Identificar si la víctima de violencia tiene interés o se encuentra preparada para realizar la denuncia, coordinar con el CEM de su jurisdicción.
- Referir a los servicios de salud mental.

Paso 4: Verificar la comprensión de sus derechos y mecanismos de protección

El consejero pide a la víctima que explique verbalmente y con uso de flujograma o gráficos:

- Qué proceso de atención o servicios existen para atender la violencia.
- Cuáles son los pasos que debe seguir para el acceso a la justicia y con qué instancias cuenta en su localidad para recibir el apoyo.
- Cuáles son los ciclos de la violencia, qué caracteriza cada ciclo y si es posible que identifique en qué fase del ciclo se encuentra y los cuidados que debe aplicar.
- Con quiénes cuenta para buscar apoyo en su entorno personal, familiar, laboral o comunal si ocurre la violencia familiar.
- Hay que recordar que es el momento para reforzar los mensajes correctos y clarificar las dudas e imprecisiones.

Paso 5: Mantener la relación cordial y establecer plan de seguridad y seguimiento

- Elaborar y consensuar con la víctima de violencia el plan de intervención.
- Realizar interconsulta con otros servicios o referencias según sea el caso.
- Elaborar el plan de seguridad en caso de que se haya identificado en la víctima riesgos para su vida o exista la sospecha que se puede producir una agresión por parte de la pareja.
- Despedirse de la víctima expresándole que es una persona valiente, muy valiosa y que puede volver al servicio, según el plan de intervención acordado o en cualquier momento cuando lo requiera.

Violencia sexual

En los servicios de salud, una especial atención merece el tema de violencia sexual ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Una primera acción en los servicios de salud sexual y reproductiva es el tamizaje para detección de violencia familiar que se realiza a las gestantes y mujeres en edad fértil, se brinda consejería y ante la identificación de casos positivos de violencia deben ser derivados a servicios especializados para una atención integral, oportuna, y multisectorial, de ser el caso.

Los consejeros de salud sexual y reproductiva y todo proveedor de salud deben observar los siguientes signos y síntomas, que son manifestaciones que sugieren casos de violencia sexual, y debe ser confirmada o descartada la sospecha:

- Problemas en la salud mental: Estrés, depresión o ansiedad.
- Lesiones físicas recurrentes sin explicación.
- Antecedentes de violencia física.
- ITS.
- Embarazos no deseados.
- Dolores y/o problemas de salud en el aparato reproductor, por ejemplo, infecciones en las vías urinarias o dolores pélvicos.
- Consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
- Manifestación de ideas suicidas.

6.7.10. CONSEJERÍA PARA MUJERES EN LA ETAPA DEL CLIMATERIO

Objetivo: La consejería en este periodo tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida, aliviar la sintomatología somática, psicológica, genitourinaria y sexual asociada con esta etapa.

El climaterio, incluida la menopausia, es un ciclo más en la vida. La OMS define a la menopausia como *"el cese permanente de la menstruación producido por la detención de la actividad ovárica"*, y al climaterio o perimenopausia *como "el período en el cual comienza la declinación de la fertilidad"*, con los característicos cambios endocrinológicos, biológicos y clínicos. En este periodo todavía existe riesgo de embarazo ya que es posible la ovulación espontánea ocasional.

El consejero informa a la persona usuaria que el climaterio no es una enfermedad ni un proceso patológico, que los signos y síntomas están asociados a los cambios hormonales, muchas mujeres tienen pocos o ningún síntoma mientras que otras manifiestan tenerlos de manera más intensa, que pueden ser cambios en el patrón menstrual, bochornos, cambios en el estado de ánimo, insomnio, dolores articulares, entre otros.

Toda mujer es informada sobre los cambios que experimenta en este periodo, comprendiendo que el climaterio, entre los 45 y 65 años, es un proceso natural que les ocurre a todas las mujeres, pudiendo presentarse, en ocasiones, a edades más tempranas.

Las personas usuarias tienen dudas y preocupaciones respecto a esta importante etapa de cambios de la vida reproductiva a la no reproductiva, a los cambios físicos y

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRECC. GRAL. DE INTER. ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA

emocionales, por lo que, puede requerirse el apoyo de profesionales de la salud según la especialidad que requiera la usuaria.

La consejería va a permitir a la persona usuaria una mayor tolerancia para asimilar el proceso de cambios físicos y emocionales, así como el manejo positivo de este ciclo en su etapa de vida; por lo que, el consejero tiene en cuenta lo siguiente:

- Informar a la persona usuaria que en el climaterio puede tener cambios en la libido y lubricación genital, atrofia del epitelio vaginal, pérdida de la rugosidad de la vagina, adelgazamiento de la mucosa y disminución de la humedad, lo que trae como consecuencia la dispareunia.
- Detectar las necesidades de la persona usuaria, que puede tener temor a embarazarse o dificultades con su pareja.
- Realizar un asesoramiento reproductivo e informar de los riesgos que la edad ocasiona en la concepción en esta etapa de la vida.
- La edad, por sí sola, no es suficiente para contraindicar el uso de ningún método anticonceptivo, ya sea hormonal o no.
- Enfatizar el uso de los métodos anticonceptivos más eficaces, a fin de reducir al máximo los riesgos médicos de los embarazos no deseados entre este grupo de mujeres.
- Durante la perimenopausia, se pueden obtener beneficios añadidos de los métodos hormonales, como la regulación de los ciclos menstruales, la mejora de los parámetros de anemia, la reducción del riesgo de algunos tipos de cáncer y el mantenimiento de la masa ósea.
- Abordar la consejería con respeto y tolerancia, sobre todo evitando juicios morales.
- Informar a la persona usuaria sobre la identificación de riesgo para osteoporosis, enfermedad cardiovascular, la importancia de contar con un diagnóstico precoz de cáncer de mama y cuello uterino y promover su atención.

La consejería debe incluir intervención multidisciplinaria de los siguientes temas:

- Anticoncepción en la perimenopausia.
- Impacto de los cambios hormonales.
- Sexualidad en el climaterio y la post menopausia.
- Estilos de vida saludables.
- Nutrición saludable.
- Controles médicos periódicos, entre otros.
- En caso de ser necesario, se debe derivar a la usuaria a un programa de atención integral que incluya evaluación por especialista, apoyo emocional y social.

6.7.11. CONSEJERÍA EN PROBLEMAS DE FERTILIDAD

Objetivo: Brindar información a la persona usuaria y a la pareja sobre salud reproductiva y problemas de fertilidad, despejar dudas e inquietudes respecto al diagnóstico, tratamiento y expectativas de éxito, y se tomen decisiones voluntarias e informadas con apoyo especializado

Con la finalidad de contribuir con alternativas de solución ante el problema identificado, el consejero realiza las siguientes acciones:

- Brindar la información necesaria sobre los problemas de fertilidad, tratamientos y expectativas de éxito. Las personas con infertilidad no presentan síntomas, existen factores de riesgo que afectan a ambos sexos, como la edad avanzada, el consumo excesivo de tabaco o alcohol, los trastornos alimenticios y el exceso de ejercicio.
- Recabar información, preguntando por sus antecedentes, saber si la persona usuaria es diabética, usa fármacos, es fumadora, si tuvo ITS, si está expuesta a radiactivos, así como conocer cuál es su ocupación laboral.
- Brindar información sobre factores de riesgo, posibles efectos colaterales del tratamiento, condiciones y procesos de fertilidad asistida.
- Verificar la comprensión sobre los diferentes aspectos físicos y emocionales que involucra la decisión tomada.
- Recordar que la infertilidad puede generar en las personas sentimientos de

frustración, desmoralización y desesperanza; por lo que, es importante que la persona usuaria sea derivada al especialista para apoyo en salud mental.

Durante el proceso de tratamiento, es importante identificar, comprender y modificar aspectos personales, familiares y sociales adquiridos por la persona usuaria y su pareja durante el desarrollo de la personalidad que puedan dificultar la aceptación del problema de fertilidad y/o del tratamiento.

El consejero, teniendo en cuenta que este es un problema que puede generar dificultades psicológicas a la persona usuaria, como disminución de la autoestima, sentimiento de culpa, mal manejo de las relaciones interpersonales, problemas relacionados a su vida sexual, depresión, problemas psicosomáticos entre otros, deriva o refiere a la persona usuaria a servicios especializados de salud mental y otros, según necesidad.

6.7.12. CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER

Objetivo: Brindar información personalizada para que la persona usuaria conozca y comprenda los factores de riesgo asociados con un aumento de la probabilidad de ocurrencia de cáncer, así como intervenciones dirigidas a mejorar los estilos de vida, promoción en el uso de los servicios de salud y fomentar la detección precoz y tratamiento oportuno.

En el caso de la consejería para la prevención del cáncer de cuello uterino, esta se sujeta a lo dispuesto en la Directiva Sanitaria N° 165-MINSA/DGIESP-2025, Directiva Sanitaria para la prevención del cáncer de cuello uterino, aprobada por Resolución Ministerial N° 480-2025/MINSA, o la que haga sus veces, realizándose en personas aparentemente sanas comprendidas entre los 25 años hasta los 64 años, independientemente del motivo de consulta o contacto con los servicios de salud, como mínimo 2 consejerías por año, con intervalo de 1 mes entre la primera y segunda.

La consejería en prevención de factores de riesgo para el cáncer es transversal a las etapas de vida; sin embargo, es importante abordar el problema de cáncer de cuello uterino y de mamas en las mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores.

El consejero brinda información sobre los principales factores de riesgo que están presentes en el cáncer de cuello uterino:

- Presencia o antecedentes de infección persistente por el VPH.
- Coinfección o antecedentes de otras ITS.
- Inicio precoz de RS (antes de los 16 años).
- Tener varias parejas sexuales (2 ó más).
- Tener una pareja sexual que ha tenido o tiene muchas parejas sexuales.
- Multiparidad (4 o más gestaciones).
- Uso prolongado de anticonceptivos orales combinados por más de 5 años.
- Tabaquismo (fumadora activa o pasiva).
- Condiciones del huésped que comprometen la inmunidad (por ejemplo, inactividad física, mal estado nutricional, y la infección por VIH y uso prolongado de corticoides).

El principal factor de riesgo para cáncer de cuello uterino es la infección persistente de VPH; este es potencialmente transmisible y se considera hoy como la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la mayoría de las poblaciones. Aunque muchas de las mujeres infectadas por el virus se negativizan en los 2 siguientes años a la infección, las que presentan persistencia de infección están en mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical.

En la consejería, además de brindar información sobre la prevención de los factores de riesgo, se promueven las siguientes actividades de prevención:

- Vacunación contra el VPH, conforme lo establece la NTS N°196-MINSA/DGIESP-2022 "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación", aprobada por Resolución Ministerial N° 884-2022/MINSA, o la que haga sus veces.
- Uso de preservativo en las RS. El VPH se transmite de una persona a otra durante

el contacto de piel a piel con una zona infectada del cuerpo.
- Evitar el consumo de alcohol y el tabaco. Existe suficiente evidencia epidemiológica para relacionar el consumo de tabaco como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de cuello uterino.
- Realización de examen clínico, pruebas de tamizaje de acuerdo con la edad y pruebas de detección temprana.
- Alimentación saludable y mantener un peso adecuado, consumo de agua, frutas y vegetales, vitaminas y fibras; disminuir el consumo de azúcares y alimentos con alto contenido de grasas de origen animal y de carnes rojas.
- Promoción de estilos de vida saludables, como actividad física y evitar la obesidad.

Considerando que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, el consejero hace énfasis en los siguientes mensajes:

- Informa a las mujeres los síntomas más comunes asociados con el cáncer de mama, como bultos y espesamientos, y les explica que una evaluación rápida y una detección temprana mejora el resultado.
- Instruye a las mujeres para que comprendan mejor sus riesgos y promueve el uso de los servicios de salud para detección precoz mediante el examen clínico de mamas (ECM) y la mamografía bilateral de tamizaje. Debe quedar claro el mensaje de que la mayoría de las mujeres diagnosticadas en etapa temprana tienen un buen pronóstico.
- Refuerza el mensaje del ECM en toda mujer a partir de los 40 años y la mamografía bilateral, como los medios de tamizaje más importantes para la detección de cáncer de mama. El ECM es realizado por médico especialista en ginecología y obstetricia; médico de familia y comunidad, médico cirujano u obstetra.
- Instruye sobre la técnica del autoconocimiento de mamas, como una herramienta complementaria a la educación para que la usuaria conozca y comprenda por la palpación, la consistencia y apariencia normal de sus mamas, y busca cambios en sus características o si nota que una mama es diferente en comparación con la otra (Ver Anexo 4).

Antes de concluir la consejería, se deben aclarar dudas y conceptos que la usuaria haya manifestado durante la misma, usando el material educativo de apoyo y un lenguaje adecuado que garantice la comprensión de la información brindada.

6.7.13. CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VIH Y HEPATITIS B

Objetivo: Brindar información sobre conductas sexuales de riesgo para una ITS, incluido el VIH y temas relacionados con la prevención, motivando el logro de cambios de conducta en personas con riesgo de adquirir ITS, reconocimiento de síntomas y promover la búsqueda de servicios para tratamiento en caso de tener el diagnóstico, interrumpir la cadena de transmisión y evitar la reinfección.

La consejería está dirigida a aquellas personas que desean orientación sobre ITS, VIH y HB debido a que ya iniciaron RS, presentan conductas sexuales de riesgo, sospechan tener alguna de estas infecciones o tienen signos y/o síntomas.

Las ITS son causadas por bacterias, virus y parásitos que se trasmiten a través del contacto sexual. Algunas ITS no causan síntomas, otras pueden producir malestar o dolor; la mayoría de estas infecciones son tratables y muchas de ellas pueden curarse. Si no se tratan pueden producir, de acuerdo con el tipo de infección, diferentes problemas de salud: Infertilidad; enfermedad inflamatoria pélvica; predisposición o mayor riesgo de tener embarazo ectópico (en una trompa); problemas neurológicos; mayor riesgo de adquirir VIH; el VPH no tratado puede relacionarse con algún tipo de cáncer.

Algunas ITS pueden ser transmitidas por la madre a su bebé durante el embarazo, parto o en la lactancia.

Por ser un tema ligado al comportamiento sexual de las personas o de sus parejas, la consejería debe desarrollarse en un lugar donde se garantice la privacidad y se debe

manifestar la confidencialidad desde el inicio de la sesión, con empatía y confianza orientado a ofrecer soporte emocional, información y educación sobre el cuidado de su salud.

En la persona usuaria debe quedar claro el mensaje que los siguientes comportamientos sexuales pueden aumentar la exposición a las ITS:

- Tener RS sin condón.
- Tener RS con una persona que tiene síntomas de ITS.
- Inicio precoz de RS.
- RS con múltiples parejas.
- Tener RS bajo el efecto del alcohol.
- El consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual (chemsex)
- Cambiar frecuentemente de parejas sexuales.
- Mantener contacto sexual con parejas "casuales", trabajadoras y/o trabajadores sexuales (TS) o sus clientes sin protección.
- Hombres o mujeres que tienen múltiples parejas sexuales simultáneas.
- Tener RS bajo coerción o violencia.
- Haber tenido una ITS durante el último año, ya que se corre el riesgo de volver a contraer la infección si no se modifica la conducta sexual.
- Sexo anal sin condón.
- Uso compartido de juguetes sexuales.

Consideraciones a tener en cuenta durante la consejería:	• Respeto por la persona usuaria, considerando lo difícil que es expresar sus temores y dudas acerca de su comportamiento sexual. • Hay que explicar que algunas preguntas pueden resultar incómodas, pero que esa información es necesaria para orientar la consejería. • Evitar hacer juicios de valor, ya sea verbales o gestuales. • Evite realizar preguntas y calificativos de juicio moral. • Realizar preguntas, de preferencia, abiertas con frases educadas y respetuosas. • Usar un tono de voz amigable. • No involucrarse ni tomar decisiones por la persona usuaria. • Hay que recordar que el consejero no está para resolver problemas ni dar soluciones. • Brinde información básica, comprensible y actualizada, fomente el uso responsable y correcto de los preservativos, refuerce su importancia ya que son los únicos dispositivos que reducen la transmisión del VIH, HB y las ITS, y previenen los embarazos no deseados, es lo que se denomina "doble protección"; informar que estos se encuentran en todos los establecimientos de salud y son de distribución gratuita. • La información proporcionada permite también a las personas tener elementos de apoyo para decidir libre y voluntariamente a realizarse el examen de detección del VIH, sífilis y de HB, a fin de ser diagnosticados oportunamente y, de resultar positivo, ser referidos a los servicios de salud para evaluación e inicio de tratamiento.

Para el abordaje de las ITS es importante considerar las 4C: Consejería, manejo de contactos, cumplimiento del tratamiento y uso de condones, conforme se detalla a continuación:

- **Consejería**. La información que se brinda debe ser lo más completa y comprensible para la persona usuaria; la metodología aplicada es muy importante en este momento.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECC. GRAL. DE INTER. ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA
DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- **Manejo de Contactos**. Es la pareja o las parejas de una persona diagnosticada con una ITS, cuya identificación y localización deben ser realizadas con respeto y confidencialidad, y tiene como fin proporcionarle información y realizar un diagnóstico precoz y tratamiento de ser necesario. En los casos relacionados a los resultados de las pruebas de diagnóstico de VIH/SIDA y en todo el proceso de atención, debe primar la confidencialidad y protección de datos personales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 26626, Ley que encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual.
- **Cumplimiento del tratamiento**. A partir de los síndromes detectados o los resultados de laboratorio obtenidos, ofrecer a la persona usuaria el tratamiento adecuado. Señalar los riesgos de una reinfección y explicar la importancia del cumplimiento al tratamiento indicado.
- **Uso de Condones**. En una RS, promover el uso de condones masculinos o femeninos para disminuir las posibilidades de adquirir una ITS, hacer énfasis que el condón además de proteger de un embarazo es el único método anticonceptivo que proporciona protección contra ITS; el consejero señala las condiciones para una buena conservación del insumo, hace una demostración del uso adecuado y al finalizar la sesión de consejería hace entrega del insumo.

Con relación a la consejería a poblaciones con alto riesgo de infección por VIH, como hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transgénero (MT), TS y parejas serodiscordantes, es importante mencionar, que además de las formas de prevención para adquirir ITS-VIH, existen otros métodos de prevención, como la Profilaxis Preexposición (PrEP) que consiste en la administración de medicamentos antirretrovirales antes de una exposición o posible exposición sexual a VIH, el cual se brinda en los establecimientos de salud.

Asimismo, en la consejería, poner especial atención en mujeres en edad fértil y gestantes para la detección del VIH, sífilis y la HB, debiendo dar información detallada sobre:

- El VIH, efectos sobre el sistema inmunológico, la historia natural de la infección y el riesgo de infectar al bebé, si la madre resulta seropositiva.
- Los riesgos y probabilidades de trasmitir el VIH a su hijo durante el embarazo, el parto y a través de la LM si es una mujer VIH (+).
- La prueba de tamizaje, el procedimiento de prueba rápida de HB, VIH o prueba de ELISA, qué significa un resultado reactivo o no reactivo.
- En gestantes VIH (+), consejería para el autocuidado y cumplimiento estricto del tratamiento antirretroviral, controles de seguimiento, medidas para reducir la transmisión madre-hijo, medidas sobre LM.
- El riesgo de sífilis congénita y sus complicaciones si la gestante reactiva a sífilis no recibe tratamiento adecuado y oportuno.
- La gratuidad del tratamiento antirretroviral para las personas viviendo con VIH y personas diagnosticadas con sífilis y la importancia de sus controles periódicos.
- Esquema de vacunación para niños y adultos contra la HB.
- Las diversas opciones de métodos anticonceptivos de larga duración que se proveen gratuitamente en todos los establecimientos de salud, entre otros.

6.7.14. CONSEJERÍA EN LA TRANSMISIÓN SEXUAL DEL VIRUS ZIKA

Objetivo: Informar sobre los riesgos de exposición que tienen las mujeres en edad fértil y las gestantes a la infección por dengue, chikungunya y, especialmente, por Zika, para mejorar las prácticas y cuidados domiciliarios de protección frente a estas metaxénicas.

La población en general debe tomar acciones de prevención de la infección por dengue, chikungunya y Zika; sin embargo, las mujeres embarazadas deben tener especial cuidado con el virus Zika, dado que se ha relacionado la infección de la madre con enfermedades en el RN, como microcefalia y otras anomalías. También se ha asociado el virus del Zika con un síndrome neurológico que causa parálisis de brazos y piernas, conocido como Síndrome de Guillain-Barré (SGB).

Para mujeres en edad fértil

A toda mujer en edad fértil atendida en los servicios de salud se le debe preguntar e investigar sobre su lugar de residencia o viajes recientes a zonas catalogadas como epidémicas o endémicas con transmisión de virus Zika. Informar y orientar respecto a:

1. La prevención domiciliaria para evitar presencia del vector como: Protección y aseo de recipientes de almacenamiento y conservación de agua (tapado y limpieza).
2. Prevenir la reproducción de mosquitos Aedes aegypti, a través de la eliminación y control de posibles criaderos en el interior y exterior de las viviendas (eliminación de llantas, recipientes en desuso), entre otros.
3. Los cuidados para evitar picaduras del vector, como el uso de vestimenta que cubra la piel expuesta, el uso de repelentes también puede ayudar.
4. Usar mosquiteros durante las horas de descanso, así como mallas en puertas y ventanas, que evita el contacto de la persona con el vector.

Se debe identificar a la mujer en edad fértil con inicio de RS, indicándole evitar contacto sexual sin protección. Brindar información sobre:

1. Los síntomas de la enfermedad por virus Zika: El síntoma más común del Zika es la erupción en la piel o sarpullido, a menudo acompañada de prurito (picazón) y fiebre leve. También puede causar conjuntivitis sin pus (enrojecimiento de los ojos), dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, malestar general, que comienza 2 a 7 días después de la picadura de un mosquito infectado.
2. El riesgo de transmisión sexual del virus Zika y las posibles complicaciones en el feto y en el RN si se embaraza (microcefalia, malformaciones congénitas, meningoencefalitis, mielitis, entre otros) y dónde solicitar atención médica.
3. Consejería en metodología anticonceptiva, que comprenda:
   - Énfasis en métodos anticonceptivos seguros.
   - Prevención de un embarazo de riesgo.
   - Entrega del método anticonceptivo elegido, respetando los derechos de las usuarias.

En usuarias que usen u opten por el uso de preservativos, brindar consejería y demostración sobre el uso correcto de preservativos masculino o femenino, como protección para evitar la trasmisión sexual del virus del Zika.

Para gestantes en riesgo o sospecha de haber contraído Zika

Las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo que el resto de la población de estar infectadas con el virus Zika; sin embargo, en la gestante se ha asociado al riesgo de las complicaciones en el feto y en el RN (microcefalia, malformaciones congénitas, SGB, meningoencefalitis, mielitis, entre otros).

El consejero debe promover que las mujeres embarazadas acudan a sus consultas prenatales e informarles que no todas las personas presentan síntomas evidentes de la infección.

Por lo general, las personas que se infectan con Zika no se sienten lo suficientemente enfermas como para buscar un servicio de salud; sin embargo, si una mujer embarazada que vive en un área con riesgo de Zika o viajó hace poco a un área afectada presenta alguno de estos síntomas, como erupción en la piel o sarpullido a menudo acompañada de fiebre leve, conjuntivitis sin pus, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, malestar general, debe acudir de inmediato a los servicios de salud aunque no tenga una cita.

Para la infección con Zika no hay vacuna ni un medicamento específico contra este virus, sólo se pueden tratar el prurito, el dolor y la fiebre. Se debe monitorear la gestación y al

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRECC. GRAL. DE INTER. ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA

RN, y, si hay sospecha de posible infección, se puede hacer una prueba de laboratorio que puede confirmar o descartar la enfermedad.

6.8. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A GRUPOS ESPECÍFICOS

6.8.1. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

Para la consejería de adolescentes, el consejero debe estar capacitado en la atención de salud de adolescentes, que incluya la identificación de las conductas más frecuentes en dicho grupo, así como reconocer los cambios físicos y sexuales, emocionales, psicológicos y sociales que experimentan y cómo influyen en su sexualidad, características de la adolescencia, los derechos sexuales, factores que protegen la salud del adolescente y comportamientos de riesgo, autoestima, comunicación asertiva, control de emociones (cólera o rabia), entre otros.

A pesar de que la salud de los adolescentes es considerada como un elemento básico para su desarrollo social y económico, este grupo ha permanecido vulnerable debido al limitado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como insuficiente educación sexual en las instituciones tutelares del sistema educativo.

La consejería en adolescentes esencialmente está dirigida a la prevención y al fomento de la salud, a identificar y evitar situaciones de riesgo, un embarazo no planificado, prevención de ITS, VIH, HB y otros riesgos asociados a las conductas sexuales, en el marco de la normatividad vigente.

Otro tema importante que debe ser abordado especialmente con las adolescentes es el conocimiento y la actitud frente a la menstruación, es decir, información sobre su naturaleza fisiológica, periodicidad, características y los cuidados e higiene al utilizar diferentes tipos de productos para la contención que pueden ser toallas higiénicas descartables, tampones, entre otros.

Es frecuente encontrar en las adolescentes escasa información sobre los cuidados durante la menstruación y, lo poco que conocen, se recibe tardíamente cuando ya experimentaron situaciones de estrés y angustia al ser sorprendidas por la primera menstruación. Esta experiencia hace que sea asociada permanentemente a sentimientos de vergüenza y temor, que a veces son reforzados por la familia, la escuela y la comunidad al no hablar sobre el tema; la escasa información sobre el tema trae como efecto el ausentismo escolar durante los días de la menstruación.

Entonces la consejería debe estar orientada a la naturalización de la menstruación para que sea asumida por las niñas y adolescentes con responsabilidad, dignidad y confianza, que les permita un manejo apropiado de su salud menstrual.

La consejería para este grupo específico se debe brindar con la misma metodología expuesta en el modelo de los 5 pasos.

Principios básicos de la consejería para la persona usuaria adolescente

- Debe estar centrada en las necesidades y requerimientos de los adolescentes, de acuerdo con la etapa de desarrollo, conocimientos, intereses, cultura, etnia, valores, entre otros.
- Debe promover el buen trato y generar empatía con el adolescente para desarrollar confianza, seguridad y continuidad en la atención.
- Consecuente con el principio de no discriminación, se entrega consejería, respetando y aceptando lo que cada persona es, no lo que hace. A través del lenguaje y la comunicación no verbal, se expresa consideración positiva hacia la persona. No se juzga la conducta, aún cuando no esté de acuerdo con lo que dicen o hacen.
- No es "*aconsejar ni dar directrices*", es facilitar la información fidedigna y oportuna, es comprender y apreciar que el cambio de conducta se facilita cuando la persona participa en la solución de sus problemas, toma sus propias decisiones y define sus opciones en base a la información y sus propias necesidades.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECC. GRAL. DE INTER. ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA
DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- Las personas avanzan hacia la madurez, resolviendo dificultades mediante la exploración y comprensión de sí mismos y actuando en base a sus propias decisiones.
- La escucha activa es la base de la consejería. Escuchar activamente no es un proceso fácil, más que una facultad, física o intelectual, es un proceso psicológico que involucra interés, atención, motivación.

Momento para brindar la consejería	• La consejería se brinda a todos los adolescentes que acuden al servicio y solicitan la atención, manteniendo siempre el principio de confidencialidad y respeto en la relación proveedor-usuario. • La visita domiciliaria también constituye un espacio de oportunidad para brindar la consejería al adolescente cuando no puede acudir al establecimiento de salud. • Desarrollo de la sexualidad, esta etapa es el centro de atención por las repercusiones biopsicosociales que puede tener en la vida actual y futura en adolescentes que han mantenido RS sin consentimiento, que han sido víctimas de abuso sexual, o que no han accedido a la información adecuada en torno a la prevención, o han iniciado RS sin la protección necesaria. • Se debe tener especial atención a las adolescentes que son sexualmente activas, por el riesgo de embarazo, riesgo de contraer una ITS o VIH-SIDA, las que tienen antecedente de embarazo o aborto, y a las que posiblemente sean víctimas de violencia sexual o se encuentren en situación de desventaja.
Información que se brinda	• Sobre aspectos relacionados a su desarrollo psíquico y social, así como a sus relaciones interpersonales, necesidades de atención y el proceso de enamoramiento en esta etapa de desarrollo, así como las habilidades para la vida. • Sobre fisiología de la reproducción, proceso del ciclo menstrual, higiene y manejo de la menstruación, sexualidad y cambios corporales, relaciones afectivas y libres de violencia previniendo el abuso sexual y maltrato, opciones anticonceptivas, AOE, consecuencias y riesgos del embarazo no planificado, prevención de ITS (especialmente sobre VPH y prevención de cáncer ginecológico), VIH/SIDA, para facilitar la toma de decisiones sobre su vida sexual. • Prestar especial atención a los silencios, pues pueden tener diferentes significados; el adolescente puede estar pensando sobre lo que se acaba de hablar, no atreverse a hablar por timidez o vergüenza debido al tipo de problema que quiere contar o simplemente no saber cómo contar lo que le sucede. En este momento, es necesario utilizar preguntas abiertas, parafrasear, utilizar lenguaje sencillo. • También se brinda información sobre factores de riesgo, como tipos de violencia, consumo de alcohol, drogas, pandillaje u otras, así como referencias a quién y dónde solicitar ayuda en caso de enfrentar estos problemas. • Sobre la importancia de *"habilidades para la vida para la interacción efectiva"*, son recursos para promover conductas deseables, tales como la socialización, la mejora de la comunicación, la toma efectiva de decisiones, la solución de conflictos y la prevención de conductas de riesgo.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRECCIÓN GRAL. DE INTER ESTRATEGIAS EN SALUD PÚBLICA

	Sobre anticoncepción En general, las adolescentes deben tener acceso a información sobre los métodos anticonceptivos. Si bien la edad en sí no constituye una razón médica para negar un método, deben tomarse en cuenta aspectos legales, sociales y conductuales para la elección de estos. En algunos casos, la elección del método puede estar influenciada por factores, como las RS esporádicas, la necesidad de ocultar su actividad sexual, antecedentes obstétricos, entre otros. Cada adolescente es único y como sujeto de derecho puede elegir voluntariamente un método anticonceptivo, exceptuando los métodos quirúrgicos.

6.8.2. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA VARONES

Generalmente, los varones no se sienten cómodos al asistir a los servicios de salud sexual y reproductiva, observando que el mayor porcentaje de usuarias son mujeres. Es posible que algunos varones puedan sentirse más cómodos si la consejería sobre su salud sexual y reproductiva la hace una persona de su mismo sexo.

Momento para brindar la consejería

Cualquier momento que el usuario asista al establecimiento de salud en busca de información es oportuno para brindársela; sin embargo, es recomendable que este servicio sea en un espacio y horario especial para facilitar el acceso de los usuarios que, por diversas razones, no acuden a un establecimiento de salud.

La información que se brinda comprende los derechos sexuales y reproductivos, sexualidad, la reproducción, fisiología femenina y masculina, planificación familiar, ITS, VIH/SIDA, prevención de factores de riesgo para el cáncer, prevención de la violencia, entre otros temas.

En este aspecto es muy importante el rol del consejero para sensibilizar a los varones y que comprendan que son personas sujetas de derechos sexuales y reproductivos, que individualmente o con la pareja compartan la responsabilidad del cuidado de su salud sexual y reproductiva.

La consejería es proporcionada en función de sus necesidades de salud sexual y reproductiva, y, según lo que se ha observado frecuentemente como motivo de búsqueda de los servicios de salud, tanto por jóvenes como por adultos, es para información por sospechas de contagio de ITS, incluso VIH, y, por otro lado, su intención para la práctica de la anticoncepción.

Es importante rescatar la participación del varón en el ámbito de la paternidad responsable y cuidados de su salud sexual y reproductiva; y, por lo mismo, el consejero debe motivar a recibir otras prestaciones de salud que van a contribuir a prevenir los riesgos en su salud y reforzar conductas de protección a enfermedades futuras, como la detección de VIH, sífilis, HB; consejería para la reducción de factores de riesgo para el cáncer en general, vacunación contra la HB, entre otros.

6.8.3. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Aunque los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos a nivel internacional como parte de los derechos humanos, las personas con discapacidad y, especialmente las mujeres que tienen dicha condición, aún encuentran barreras que afectan el reconocimiento y goce pleno de sus derechos con servicios de salud accesibles e inclusivos.



En ese contexto de la realidad, como proveedores de los servicios de salud sexual y reproductiva, se promueve la equidad sanitaria y la inclusión real de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, reconociendo sus habilidades y capacidades, prestar servicios sobre la base de la ética y el respeto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad.

Asimismo, se reconoce que todas las personas con y sin discapacidad tienen necesidades de salud, para lo cual se promueve servicios de calidad, accesibles, gratuitos y asequibles. Es importante informar en la consejería que vivir la sexualidad no incluye únicamente el acto sexual, sino aceptar y cuidar el cuerpo, enamorarse, vivir el erotismo y el placer, tomar decisiones propias en cuanto a tener o no familia, casarse, cuándo y cuántos hijos tener, entre otros aspectos. La sexualidad de las personas con discapacidad no es mejor ni peor que la de los demás, es una experiencia personal, con la posibilidad de encontrar la forma de vivirla y experimentarla.

Se debe prestar especial atención en que sea la persona con discapacidad quien exprese su consentimiento, de conformidad con el Código Civil.

El consejero para cumplir adecuadamente sus funciones debe contar con conocimiento relacionado a la salud sexual y reproductiva y cómo orientarla considerando las condiciones físicas, mentales y sensoriales de las personas con discapacidad que permita interactuar de manera efectiva con mensajes a ser comprendidos y aplicados en su real dimensión.

Los aspectos que deben ser tratados en los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva son:

- La afectividad y el disfrute en la RS.
- Higiene y cuidados para la salud menstrual.
- Los compromisos de vivir en pareja.
- Información sobre prácticas adecuadas a la condición de discapacidad y dificultades en las relaciones sexuales.
- Condición de salud y riesgos para la concepción.
- Planificación familiar y formas de evitar un embarazo.
- Uso de métodos anticonceptivos temporales y definitivos.
- Atención prenatal, parto y puerperio.
- Los cuidados de la madre y su bebé después del nacimiento y planificación del espaciamiento de nuevos embarazos.
- La participación del padre durante el embarazo, parto y puerperio.
- Prevención de ITS, VIH-SIDA.
- Prevención y atención de la violencia.
- Detección oportuna de cáncer de cuello uterino y próstata

6.8.4. CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

Las personas que se encuentran privadas de su libertad obviamente gozan del derecho constitucional a la salud al igual que cualquier persona; sin embargo, en este caso, por su condición de reclusión y no ser capaz de subsanarla por sí misma, el Estado es el que asume la responsabilidad de su salud. En esa medida, es su responsabilidad el cuidado de la vida, la salud, la integridad física y psicosocial, así como procurar las condiciones mínimas de existencia digna como persona y proveer lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción atención y recuperación de la salud.

El derecho que tienen las personas internas en centros carcelarios a conservar su vida sexual, y a seguir con el desarrollo de su vida íntima no debe ser vulnerado por la circunstancia de reclusión en la que se encuentran, ya que las visitas implican la salvaguarda del derecho a la intimidad personal y familiar y repercute a una estabilidad emocional de la persona privada de la libertad, además que con ello se está garantizando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, apoyando el paso a la resocialización

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRECC. GRAL. DE INTER. ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA

La administración penitenciaria tiene la responsabilidad de asegurar la accesibilidad y continuidad de atención de salud, incluida la salud sexual y reproductiva en las instalaciones designadas para tal fin.

En ese contexto, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas privadas de su libertad, y, específicamente, en las mujeres busca evitar embarazos no deseados, prevención de ITS, VIH y HB, así como prevención de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, prevención de violencia sexual.

La consejería en salud sexual y reproductiva se realiza cuidando la privacidad, confidencialidad y dignidad de las personas, en el caso de los varones privados de su libertad, toma especial interés la consejería en prevención de las ITS, VIH, HB y otros comportamientos sexuales de riesgo; sin embargo, tomando en cuenta las necesidades especiales de las mujeres en edad reproductiva, tanto de mujeres privadas de su libertad, o como pareja de varones en situación de privación de libertad, los temas de la consejería principalmente están relacionadas a sus intenciones reproductivas y uso de métodos anticonceptivos; cuidados en el embarazo; prevención y tratamiento de las ITS, VIH/SIDA, HB; tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino y mama; entre otros, atenciones que deben realizarse con las mismas características y los mismos derechos como si se hiciera fuera del establecimiento penitenciario.

6.9. REGISTRO E INFORMACIÓN

La responsabilidad del registro de atenciones de consejería en salud sexual y reproductiva en la historia clínica, el sistema HIS-MINSA, Wawared u otro sistema vigente corresponde al profesional de la salud que realiza la actividad tanto en el establecimiento de salud como durante las actividades extramurales.

Los datos generados se almacenan, se procesan y se interpretan para:

- Llevar un control de los servicios que se brinda.
- Obtener estadísticas.
- Obtener datos epidemiológicos.
- Elaborar perfiles de atención y otros.

VII. RESPONSABILIDADES

NIVEL NACIONAL

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dirección de Salud Sexual y Reproductiva), es responsable de la difusión del presente documento técnico hasta el nivel regional, así como brindar asistencia técnica para su implementación, supervisar y evaluar su cumplimiento.

NIVEL REGIONAL

La DIRESA, GERESA, DIRIS o la que haga sus veces a nivel regional es responsable de la difusión del presente documento técnico en el ámbito de su jurisdicción, así como de brindar asistencia técnica, implementarlo, y supervisar su cumplimiento.

NIVEL LOCAL

Los establecimientos de salud son los elementos articuladores responsables de la implementación y aplicación de lo dispuesto en el presente documento técnico, en lo que sea pertinente.

VIII. ANEXOS

- Anexo 1: Recomendaciones para aplicar los pasos de la consejería para la persona usuaria nueva.
- Anexo 2: Recomendaciones para aplicar los pasos de la consejería para la persona usuaria continuadora.
- Anexo 3: Preguntas más frecuentes de la anticoncepción de emergencia.
- Anexo 4: Cartilla de autoexamen de mama.

ANEXO 1

RECOMENDACIONES PARA APLICAR LOS PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA LA PERSONA USUARIA NUEVA

PERSONA USUARIA NUEVA	PASO 1 ESTABLECER UNA RELACIÓN CORDIAL: Genere un clima de confianza y empatía	PASO 2 IDENTIFICAR NECESIDADES, DUDAS E INSEGURIDADES DE LA PERSONA USUARIA: Conozca a la persona usuaria y averigüe sobre sus antecedentes	PASO 3 RESPONDER A LAS NECESIDADES, DUDAS E INSEGURIDADES DE LA PERSONA USUARIA: Oriente de manera focalizada y facilite el intercambio de información	PASO 4 VERIFICAR LA COMPRENSIÓN DE LA PERSONA USUARIA: Ayude a la persona usuaria a tomar una decisión con la comprensión de la información	PASO 5 MANTENER LA RELACIÓN CORDIAL: Asegure el uso correcto del método a través del seguimiento adecuado
CON USO PREVIO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	• Brinde confianza a la persona usuaria. • Asegure la privacidad, envite interrupciones de otras personas. • Brinde un ambiente agradable y amigable y culturalmente adecuado. • Respete los derechos de cada persona. • Tome en cuenta sus propias emociones y las de la persona usuaria. • Escuche con atención. • Averigüe el motivo de visita de la persona usuaria. • Averigüe si la persona usuaria se siente cómoda con un consejero hombre o mujer; si es posible respete la preferencia de esta.	• Pregunte con palabras comunes y fáciles de entender. • Averigüe sobre sus experiencias y conocimientos previos sobre métodos. • Conozca las preferencias de cada persona usuaria. • Averigüe sobre su relación de pareja. • Pregunte acerca de su salud para detectar contraindicaciones.	• Use palabras comunes y fáciles de comprender. • Evite dar una charla general. • Establezca un dialogo con la persona usuaria y brinde un espacio para que pregunte. • Aclare las dudas o ideas falsas. • Brinde una consejería balanceada, NO pierda tiempo hablando sobre métodos que la persona no desea o no puede usar. • Informe según lo que cada persona usuaria necesita. • Use las tarjetas de apoyo por método para facilitar la comprensión.	• Asegure la comprensión de la persona usuaria para que pueda hacer una elección informada y voluntaria. • Para saber si la persona entendió, ¡PREGÚNTELE! • Respete el tiempo que cada persona usuaria toma para decidir. • Involucre a la pareja en la decisión. Si es necesario concrete una cita con la pareja. • Refuerce la información sobre la forma de uso del método. • Pídale a la persona usuaria que repita aquellos aspectos básicos del método. • Si es necesario refuerce la información clave para el uso correcto del método. • Preste atención al lenguaje no verbal.	• Confirme los datos de la persona usuaria para poder hacer seguimiento. • Explique la importancia de los controles. • Pregúntele a la persona usuaria si podría ir al control o si es posible hacerle una visita. • Deje claro los horarios de atención. • Si es necesario, fije la fecha para el control. • No deje de dar la opción a preguntar hasta el final y aclarara dudas. • Si procede, entregue un folleto informativo sobre el método elegido.
SIN USO PREVIO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS		• Escuche con atención. • Pregunte con palabras comunes y fáciles de entender. • Indague sobre conocimientos acerca de los métodos anticonceptivos. • Averigüe lo que conoce la persona usuaria sobre salud reproductiva. • Indague sobre la relación de pareja. • Pregunte acerca de su salud para detectar contraindicaciones. • Escuche con atención.			
RECUERDA	TRATE A LA PERSONA USUARIA COMO LE GUSTARÍA SER TRATADA	CUANTO MÁS CONOZCA A LA PERSONA USUARIA SE PUEDE AYUDAR A DECIDIR MEJOR	LA INFORMACIÓN BALANCEADA AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES	LA ELECCIÓN INFORMADA AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO A LA SATISFACCIÓN DE LA PERSONA USUARIA	EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AYUDAN AL BUEN USO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO



ANEXO 2
RECOMENDACIONES PARA APLICAR LOS PASOS DE LA CONSEJERÍA PARA LA PERSONA USUARIA CONTINUADORA

PERSONA USUARIA CONTINUADORA	PASO 1 ESTABLECER UNA RELACIÓN CORDIAL: Genere un clima de confianza y empatía	PASO 2 IDENTIFICAR NECESIDADES, DUDAS E INSEGURIDADES DE LA PERSONA USUARIA: Conozca a la persona usuaria y averigüe sobre sus antecedentes	PASO 3 RESPONDER A LAS NECESIDADES, DUDAS E INSEGURIDADES DE LA PERSONA USUARIA: Oriente de manera focalizada y facilite el intercambio de información	PASO 4 VERIFICAR LA COMPRENSIÓN DE LA PERSONA USUARIA: Ayude a la persona usuaria a tomar una decisión con la comprensión de la información	PASO 5 MANTENER LA RELACIÓN CORDIAL: Asegure el uso correcto del método a través del seguimiento adecuado
CON DESEO DE SEGUIR USANDO EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO	• Brinde confianza a la persona usuaria, evite interrupciones de otras personas. • Ofrezca un ambiente agradable y amigable. • Respete las condiciones de cada persona usuaria. • Tome en cuenta sus emociones y las de la persona usuaria. • Escuche con atención. • Averigüe el motivo de la visita de la persona usuaria.	• Pregunte cómo le va con el uso del método. • Indague como ha estado su salud. • Indague acerca de la participación de la pareja. • Pregunte sobre su deseo de continuar con el método. • Escuche sus respuestas con atención.	• Use palabras comunes y fáciles de comprender. • Refuerce los temas claves para el uso del método. • Brinde un espacio para las preguntas de la persona usuaria. • Aclare las dudas o ideas falsas. • Use las tarjetas de apoyo por método para facilitar la compresión.	• Asegúrese de que la persona usuaria tiene clara toda la información para usar bien el método. • Solicite a la persona usuaria que repita la información clave sobre el método. • Pregunta sobre la forma de uso para verificar la compresión. • Refuerce aspectos que ayuden a realizar el uso correcto del método. • Preste atención al lenguaje no verbal.	• Confirme los datos de la persona usuaria. • Explique la información de los controles. • Pregunte a la persona usuaria si podría acudir al control. • Deje claro los horarios de atención. • Si es necesario, fije la fecha para el control. • Pregunte a la persona usuaria si es posible visitarla en su domicilio. • No deje de dar la opción a preguntar y aclarar dudas.
CON DESEO DE CAMBIO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO		• Pregunte sobre cómo le ha ido con el uso de método. • Identifique molestias o dificultades en el uso. • Indague sobre la opinión de la pareja respecto al método. • Determine el motivo para el cambio. • Escuche sus respuestas con atención. • Determine cuáles de los métodos podrían ser una opción para la usuaria.	• Informe de manera simple sobre los métodos alternativos para la persona usuaria. • Enfatice la información sobre los métodos de mayor interés. • Brinde un espacio para las preguntas de la persona usuaria. • Aclare las dudas o ideas falsas. • Use las tarjetas de apoyo por método para facilitar la comprensión.		
RECUERDA	TRATE A LA PERSONA USUARIA COMO LE GUSTARÍA SER TRATADA	CUANTO MÁS CONOZCA A LA PERSONA USUARIA SE PUEDE AYUDAR A DECIDIR MEJOR	LA INFORMACIÓN FOCALIZADA AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES	LA ELECCIÓN INFORMADA AYUDA A LA TOMA DE DECISION, ASÍ COMO A LA SATISFACCIÓN DE LA PERSONA USUARIA	EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AYUDAN AL BUEN USO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO



ANEXO 3

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA

Interrogantes	Respuesta
¿Cómo actúa el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE)?	Actúa principalmente bloqueando o retrasando la ovulación, al evitar que ocurra el pico de la hormona luteinizante, que es indispensable para que suceda la ovulación. Otro efecto adicional del AOE es el espesamiento del moco cervical, lo cual dificulta y retrasa el ascenso de los espermatozoides hacia las trompas de Falopio, lo cual contribuye a prevenir la fecundación.
¿El AOE interrumpe un embarazo en curso?	No, la OMS/OPS, con evidencia científica, determinó que la píldora no es abortiva pues no tiene capacidad de interrumpir un embarazo en curso cuando el óvulo fecundado ya está implantado en el útero.
¿El AOE es efectiva?	Las píldoras anticonceptivas de emergencia son más eficaces cuanto antes se tome. Si la mujer tiene RS sin protección varios días antes de la ovulación y toma una píldora anticonceptiva de emergencia, sus probabilidades de embarazo son mucho menores que si ocurriera lo mismo un día antes de la ovulación. Por eso, las píldoras anticonceptivas de emergencia deben tomarse lo más rápido posible después de una RS sin protección: Si se toma muy cerca de la ovulación, es posible que las hormonas de la píldora no puedan prevenirla y tendrá un riesgo mucho mayor de embarazo.
¿El feto resulta dañado si una mujer toma accidentalmente el anticonceptivo de emergencia estando embarazada?	No, el embarazo continúa. La evidencia científica actualizada permite afirmar categóricamente que, una vez ocurrida la fecundación, la AOE no interfiere con el proceso de implantación del óvulo fecundado y que tampoco interfiere el desarrollo embrionario de un óvulo ya implantado.
¿Es mejor tomar dosis extra del AOE?	No, solo lo que indica el profesional de salud. Explique la forma adecuada en que se debe tomar la AOE. Recomiende a la usuaria que no tome ninguna dosis extra, ya que ello podría aumentar los efectos colaterales, pero no aumentaría la efectividad.
¿Qué hacer si las píldoras han sido vomitadas?	Explique, que la dosis necesita ser repetida si la usuaria vomita dentro de 2 horas después de haber tomado el AOE. Si la usuaria tiene antecedentes de náuseas o vómitos a la ingesta de hormonas, puede ser una buena idea tomar la píldora anticonceptiva de emergencia junto a un medicamento contra las náuseas.
¿Cuáles son los efectos colaterales del AOE?	Los efectos secundarios de estas pastillas pueden incluir dolores de cabeza, dolor abdominal, sensibilidad en los senos, mareos, fatiga, náuseas y vómitos. Los efectos secundarios a menudo desaparecen después de aproximadamente un día. Los efectos secundarios tienden a ser más fuertes en las píldoras de hormonas combinadas.
¿Pueden usarse el AOE más de una vez?	Sí. Sin embargo, se recomienda que no se tome de manera rutinaria porque debido a su gran carga hormonal altera el ciclo menstrual de las mujeres. Puede retrasar o adelantar la fecha de la menstruación. Definitivamente su uso repetitivo disminuye su efectividad y podría tener más probabilidad de quedar embarazada sin desearlo.
¿Las mujeres deben usar el AOE como método anticonceptivo continuo?	No, pero sería una oportunidad importante para que la mujer empiece a utilizar un método continuo de planificación familiar. Si en el momento no desea información sobre los

	métodos anticonceptivos de uso regular se ofrece una próxima sesión.
¿Las mujeres que reciben tratamiento antirretroviral pueden usar el AOE con seguridad?	Si, sin embargo, deben utilizar un método regular de su elección. El uso sistemático y correcto de preservativos masculinos o femeninos es esencial para prevenir la transmisión del VIH a parejas sexuales no infectadas. El uso voluntario de anticonceptivos por mujeres seropositivas que deseen prevenir embarazos sigue siendo una estrategia de peso para reducir la transmisión del VIH de la madre al hijo.

ANEXO 4

CARTILLA DE AUTOCONOCIMIENTO DE MAMA[1]

Cómo realizar el autoconocimiento de mama.

Pasos:

1. Durante la ducha, ponga su mano izquierda detrás de la cabeza y examine la mama izquierda con la mano derecha y posteriormente realice el mismo procedimiento con las manos opuestas.
2. Póngase frente al espejo, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Fíjese en la piel de las mamas por si aparecen zonas salientes (nódulos) u hoyuelos, o cambios en el tamaño o aspecto de las mamas. Observe los pezones, comprobando que no estén invertidos, retraídos o fijados hacia dentro, cambios de color, escozor y descamación.
3. Luego ponga las manos en sus caderas para ampliar el pecho y las mamas, tratando de observar lo que se ha señalado en el paso 2.
4. Después ponga los brazos extendidos, para realizar, una vez más, la misma observación del paso 2.
5. Imaginando que su mama es una esfera de reloj ponga su mano derecha a las 12 en punto (arriba). Inspeccione de manera cuidadosa deslizando la forma circular los 3 dedos intermedios (índice, medio y anular) de la mano alrededor de la mama, comenzando en la periferia de la parte superior izquierda hasta llegar al pezón, tratando de palpar posibles nódulos o engrosamiento de la piel.
6. Realice la misma operación en la posición de la 1 del reloj, luego de las 2 y así sucesivamente todo el horario.
7. Cuando termine el horario, ahora vuelva a poner los dedos alrededor del pezón y con movimientos circulares, desde las 12 horas y en el sentido de las agujas del reloj vaya haciendo círculos concéntricos. Fíjese en la posible existencia de nódulos y secreción de líquido u otro fluido que sale del pezón.
8. Luego, realice una pequeña palpación del área cercana a la axila, donde puede haber tejido mamario.
9. Al terminar la exploración de una mama, debe hacer lo mismo con la otra mama, utilizando su mano contraria y siguiendo los mismos pasos.
10. Finalmente, estando acostada y colocando una almohada en el hombro derecho explore con la mano izquierda su mama derecha, y luego repita la misma operación con la mama izquierda.

Importante:
Cuando identifique la existencia de nódulos o "bultos" en una o ambas mamas, cambios en el color de los pezones, costras, dolor en los senos, secreciones de líquidos, leche o sangre, engrosamiento de la piel u otros síntomas, acuda a un servicio de salud para que le realicen un examen clínico y otras pruebas especializadas para descartar un cáncer de mama.



[1] Resolución Jefatural N°766-2018-J-INEN. Manual en Salud: Prevención del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, (Adaptado).

IX. BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Salud de Perú. Documento Técnico: Consejería en ITS/VIH y SIDA. Lima, Perú; 2009
2. Siverino Bavio, Paula. "El Derecho a la Identidad Personal". Directora del Observatorio de Bioética de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Pág. 16. Revisado en http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol58_n3/pdf/a09v58n3.pdf. Diciembre 2014.
3. Organización Panamericana de la Salud. Salud Materna y Neonatal: Atención Preconcepcional, Prenatal y Posnatal Inmediata. Bogotá; 2013
4. Ministerio del Interior de Perú. Compendio Normativo y Directorio Interinstitucional sobre trata de personas, 5° edición; 2013
5. Ministerio de Salud. Plan Nacional para la Prevención y Control de cáncer de mama en el Perú 2017 – 2021
6. Guía Práctica Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Orientaciones para los equipos de Atención Primaria 2016. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile
7. Planificación Familiar, un Manual Mundial para Proveedores, 3ra. edición 2019
8. OMS. Human reproduction programme. La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo.2018
9. Comunicaciones breves relacionadas con la sexualidad. Recomendaciones para un enfoque de salud pública OPS.2018
10. Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. OMS 2019
11. Guía sobre derechos sexuales, reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad. UNFPA Ecuador. Consejo Nacional para la Igualdad Discapacidades. 2018
12. OPS/OMS. prevención: factores de riesgo y prevención del cáncer de mama. 2016
13. Manual en Salud. Prevención de cáncer. Dirección de Control de Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Perú 2018
14. Resolución Jefatural N° 766-2018-J-INEN. Manual en Salud: Prevención del cáncer
15. Ministerio de Salud. Gobierno Nacional de Chile. Orientaciones Técnicas para la Atención Integral de la mujer en edad de Climaterio en el nivel primario de la Red de Salud (APS). 2014
16. Protocolo de atención pre concepcional. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA.2014
17. Manual del facilitador. Síntomas, complicaciones, tratamiento y medidas de prevención del dengue, chikungunya y Zika. Elaboración: Rita María Franco, Oficial de Seguridad Alimentaria Nutricional, World Vision Guatemala
18. Resolución Ministerial 442-2017/MINSA. Documento Técnico Plan Nacional para la Prevención y Control de cáncer de mama en el Perú 2017 - 2021 y control de cáncer de mama
19. OPS-OMS. Cáncer de mama: Hojas informativas para los profesionales de salud. Revisado en:https://www.paho.org/es/temas/cancer/cancer-mama-hojas-informativas-para-profesionales-salud. Setiembre 2016
20. www.paho.org/es/documentos/deteccion-temprana-concientizacion-sobre-salud mamaria y exploración clínica de las mamas.
21. Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva - PBA SSR Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas. Analía Messina-Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Argentina. Documento técnico1/2017 Consejerías en salud sexual y reproductiva de las mujeres. Herramienta para orientar el trabajo de los equipos de salud
22. Revista chilena de obstetricia y ginecología. *versión impresa* ISSN 0048-766X*versión On-line* ISSN 0717-7526. Rev. chil. obstet. ginecol. vol.83 no.1 Santiago feb. 2018
23. Guía de manejo en Atención Primaria de pacientes con Dengue, Chikungunya y Zika. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.2016.
24. Serie de Información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersex – búsqueda (bing.com).
25. Saslow, D., Hannan, J., Osuch, J., Alciati, M. H., Baines, C., Barton, M., Bobo, J. K., Coleman, C., Dolan, M., Gaumer, G., Kopans, D., Kutner, S., Lane, D. S., Lawson, H., Meissner, H., Moorman, C., Pennypacker, H., Pierce, P., Sciandra, E., . . . Coates, R.

(2004). Clinical Breast Examination: Practical Recommendations for Optimizing Performance and Reporting. CA A Cancer Journal for Clinicians, 54(6), 327-344. https://doi.org/10.3322/canjclin.54.6.327.

26. Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Cancerología ESE, 2015. Manual para la detección temprana del cáncer de mama.

